

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO EDUCACION ESPECIAL-LOGOPEDIA

MATERIAL DOCENTE EN OPCIÓN AL TÍTULO DE MÁSTER EN ATENCIÓN LOGOPÉDICA INTEGRAL

TÍTULO: Neuropsicología Cognitiva del Lenguaje y Neurolingüística.

AUTOR: Lic. Daniela de la Caridad Bertot Casals

TUTOR: Dr. C. Erislandy Omar Martínez. PT

Dr. C. Carlos Albenis Rodríguez Fernández. PT

2023

Dedicatoria

*A mi **mami** por ser un ejemplo de mujer y de superación profesional, porque sin sus empujoncitos no hubiera alcanzado la meta, por ser madre y amiga.*

*A mi **hija** por ser mi mayor inspiración y fortaleza.*

Agradecimientos

*A **Igor** por ser mi amigo, mi compañero de vida, gracias por tu apoyo mi amor.*

*A mi **Titi** porque la distancia no le ha impedido mantenerse pendiente y preocuparse por su "única hijita"*

*A **mis abuelos** por consentirme, tolerar mis maleriadeces y no aceptar que me he convertido en una mujer.*

*A **Lourdes** por ser un ejemplo de fortaleza e independencia, y porque estoy orgullosa de ser su doble.*

*A **Buggy**, mi tierno guardián.*

*A **mi familia** por su apoyo, preocupación, por ser simplemente, mi familia.*

*A **Daniela y Diamela,** mis hermanas de vida por su preocupación, por levantarme cuando el resto ni siquiera sabía que me había caído.*

*A **mis tutores** por sus conocimientos, por su tiempo y dedicación, por enseñarme andar por los caminos de la ciencia.*

*A mi **grupo de maestria** porque ser personas maravillosas*

*A mis **profesores** por ser una guía y brindarme más que conocimientos científicos.*

Síntesis

El logopeda además de brindar tratamiento logopédico debe conocer las áreas del cerebro que intervienen en el lenguaje, así mismo la relación que se establece entre ellas y el papel de cada una en el desarrollo de este proceso. Esta situación exige que se profundice en la importancia que tiene para la sociedad, la preparación de los logopedas y desde la formación significa encontrar solución a los vacíos teóricos y prácticos que se evidencia hasta el momento. Desde el campo de acción se revela una dicotomía entre las necesidades reales de los logopedas y el contenido de las actividades establecidas en su formación. El objetivo de la presente investigación es dar a conocer la solución a estas insuficiencias formativas a través de un Programa de Asignatura. Se emplearon métodos teóricos y empíricos. Desde lo formativo- académico el estudiante logra desarrollar habilidades para la exploración y el diagnóstico en neuropsicología y neurolingüística, a partir del uso pertinente de pruebas e instrumentos de evaluación neurocognitiva que le sirvan para el diagnóstico logopédico integral.

Palabras claves: Currículo, Formación inicial, Logopedia, neuropsicología, neurolingüística

Synthesis

The speech therapist, in addition to providing speech therapy treatment, must know the areas of the brain that are involved in language, as well as the relationship established between them and the role of each one in the development of this process. This situation requires that the importance for society be studied, the preparation of speech therapists and from the training it means finding a solution to the theoretical and practical gaps that have been evidenced up to now. From the field of action a dichotomy is revealed between the real needs of speech therapists and the content of the activities established in their training. The objective of this research is to present the solution to these trainig insufficiencies through a subject program. Theorical and empirical methods were used. From the academic training, the student manages to develop skills for exploration and diagnosis in neuropsychology and neurolinguistics, starting the relevant use of tests and neurocognitive innstruments that serve to apply the integral speech therapy diagnosis.

Keywords : Initial training, speech therapy, neurpsychology, neurolinguistcs

Introducción

El profesional de la educación despliega múltiples acciones en su actividad pedagógica en los diferentes contextos de actuación, lo cual exige del desarrollo de conocimientos como núcleo esencial para un desempeño profesional competente. De ahí la importante labor que deben realizar las universidades en la formación inicial y permanente del personal docente en los distintos niveles educativos.

En el caso particular de la Logopedia los profesionales o especialistas en alteraciones del lenguaje, voz, habla y audición, reciben distintas denominaciones en los distintos países. Por ejemplo, en Gran Bretaña existe el terapeuta del lenguaje o del habla (speech therapist) y el audiólogo (audiologist). En España existe el logopeda, especialista en trastornos del lenguaje y de la comunicación en general. En Latinoamérica tampoco existe una denominación uniforme, se usa mayormente el término fonoaudiólogo, pero también el de logopeda o terapista del lenguaje.

En Argentina respecto a los contenidos curriculares se incluyen anatomía y fisiología, genética, neurología, embriología, lingüística, psicolingüística, el ámbito natural de formación es la Facultad de Medicina. Nos es una carrera de índole pedagógica, pero el carácter interdisciplinario de la misma determina el desempeño profesional en otras áreas.

Por otro lado en Chile los programas se organizan principalmente en áreas de formación básica con asignaturas biomédicas y físicas (anatomía, fisiología, matemáticas, física y acústica), de ciencias humanas y sociales (psicología general, psicología educativa, lingüística general y aplicada, semántica y pragmática, psicolingüística y neurolingüística), del área de investigación (bioestadística, metodología de la investigación, seminario de investigación), y del área disciplinar-profesional: el lenguaje, el habla la voz, y la audición. En el ejercicio profesional se desempeña en los ámbitos de educación y salud.

En Colombia, por su parte, las asignaturas se organizan según área básica-científica (biología, química. física acústica, anatomía, morfología, fisiología, matemáticas,

neurociencias y patología), área social y humanística (psicología general, evolutiva y del aprendizaje, ética, psicopatología, psicolingüística, lingüística general y aplicada, fonética y fonología, semántica y sintaxis, socioantropología, ética, entre otros), área investigativa (bioestadística, epistemología, psicometría, metodología de la investigación) y componente disciplinar-profesional (el lenguaje, la audición, el habla y la voz).

La formación del logopeda es bastante similar en estos países, aunque existen diferencias en las orientaciones y modelos subyacentes. Se reconocen tres niveles de formación: materias de ciencias básicas y sociales, materias de temas fonoaudiológicos y prácticas profesionales. En tal sentido el logopeda está habilitado para atender alteraciones de la voz, la audición, él lenguaje y la deglución en niños y adultos, realizar diagnósticos fonoaudiológicos e implementar las estrategias terapéuticas. Atiende los problemas de aprendizaje escolar derivados de alteraciones lingüísticas y los trastornos cognitivos asociados a alteraciones lingüísticas en adultos.

Desde este enfoque se evidencia un perfil amplio para el desempeño profesional. En algunos países se implementan asignaturas que propician conocimientos de lingüística lo cual enriquece la formación inicial de los estudiantes.

En España se define como una profesión sanitaria regulada y reconocida que se ocupa de la prevención, detección, evaluación, diagnóstico y tratamiento de todas las alteraciones de la comunicación y de las funciones orales no verbales, tanto en la población infantil como en la edad adulta. De las asignaturas del programa vemos que cursan asignaturas como Fundamentos Médicos (I, II, III), aspectos médicos básicos; por los que si se considera una carrera asociada a la medicina (Valle, A. 2018).

En Bélgica tiene una duración de tres años y las asignaturas se organizan por bloques. El primer bloque está dirigido a estudiar el lenguaje sin patologías. El bloque 2 está dirigido a realizar prácticas y aprender recursos teóricos para desarrollar las habilidades necesarias para la evaluación del lenguaje y la comunicación. El último bloque consiste en realizar prácticas para ganar experiencia en la interdisciplinariedad, la prevención y el tratamiento de los trastornos del lenguaje (Cervera, J.F. 2020).

Desde esta mirada se muestra interesante el estudio del lenguaje sin patologías, su sistema funcional para que el estudiante pueda conocer las bases neurobiológicas del lenguaje.

En Cuba la Logopedia se define como una ciencia pedagógica especial que estudia las formas, el origen y la evolución de las distintas alteraciones del lenguaje, y elabora y aplica los principios de corrección, compensación y prevención de estas alteraciones. En el escenario de la medicina, como la rama de la medicina que se ocupa de la clasificación, estudio, tratamiento y profilaxis de los trastornos del lenguaje, del habla y de la voz (Fernández, G. 2011).

Dicha formación constituye un valioso aporte, no sólo porque incide en la corrección y desarrollo del lenguaje y la comunicación de los escolares, sino que su labor tiene impacto en el aprendizaje y en la calidad de los servicios educacionales, en los niveles de equidad y justicia social, al favorecer con su trabajo la inclusión social de niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales.

De acuerdo con las necesidades actuales y perspectivas de desarrollo del proyecto social cubano, el modelo de formación del logopeda enfatiza en la necesidad de un sistema de influencias que garantice en los estudiantes no sólo la adquisición de conocimientos, sino también que dominen los instrumentos que permiten producir el saber; saber hacer y saber ser para dar solución de forma creadora, a los problemas que se presentan en su quehacer profesional.

La labor dirigida a la corrección, desarrollo, enriquecimiento del lenguaje y de las habilidades comunicativas constituye un papel decisivo para el proceso de aprendizaje y desarrollo integral de los alumnos en todas las escuelas del país, se han elaborado varias funciones para el maestro logopeda en las cuales no se encentra la aplicabilidad de un diagnóstico integral teniendo en cuenta conocimientos de neuropsicología, neurolingüística y psicolingüística.

La formación inicial del estudiante de Logopedia en Cuba, ha experimentado constantes transformaciones en correspondencia con las exigencias que el desarrollo

científico- técnico impone a la educación, las que se traducen en diferentes modelos, planes de estudio y enfoques asumidos, donde el desarrollo de habilidades y conocimientos ha ocupado un lugar importante en cada uno de ellos.

El plan de estudio vigente (Plan E) garantiza la organización del proceso formativo. Los documentos normativos que lo conforman: el modelo del profesional, los programas de disciplinas y asignaturas contribuyen al alcance de los objetivos y fines formativos, mas resulta cuestionable su completitud.

La integración del conocimiento de las neurociencias en la formación del maestro Logopeda, es un reto que se debe asumir a partir de su pertinencia para el logro de un mejor desempeño profesional. La Junta de Acreditación Nacional adjunta al MES, en el Sistema de Evaluación y Acreditación de Carreras Universitarias, pondera el perfeccionamiento de la gestión formativa con énfasis en la actualización científica del claustro y de los contenidos del currículo. Actualmente en nuestro país, en lo que respecta a lo curricular es útil analizar la posibilidad de incluir en la formación del logopeda determinados contenidos de neuropsicología del lenguaje y neurolingüística.

Desde el modelo de profesional se exige que estos estudiantes estén preparados para comprender las necesidades personales y sociales, que sepan enfrentar con iniciativa la solución de los problemas de la práctica pedagógica e integrar al proceso formativo los avances científicos y tecnológicos. Los núcleos teóricos se centran en el enfoque histórico cultural para la implementación del desarrollo humano, el diagnóstico y la atención educativa integral, no se alude a otros enfoques y a suficientes ciencias a fines con la Logopedia que contribuyan a un diagnóstico y tratamiento integral.

La esfera de actuación de los estudiantes se ve limitada a prácticas exclusivamente educativas tanto en las escuelas especiales, urbanas y rurales. Así como miembro de los equipos multidisciplinarios de centros de evaluación, diagnóstico y orientación.

Los programas de la disciplina Logopedia garantizan metodológicamente la unidad de sus asignaturas, proyectan contenidos necesarios de psicolingüística. Las restantes disciplinas y programas de asignatura no lo conciben en su sistema de contenidos.

La disciplina Formación Laboral Investigativa se concibe como la disciplina principal integradora donde los estudiantes deben integrar conocimientos, habilidades y capacidades desarrolladas por todas las disciplinas que corresponden al año académico que cursan.

Sin embargo, actualmente se perciben insuficiencias en la práctica laboral en el proceso de caracterización y diagnóstico. Los estudiantes no logran integrar contenidos de las diferentes asignaturas para lograr el diagnóstico integral. Al no estar concebido en el currículo ninguna asignatura que aborde contenidos de neuropsicología del lenguaje y neurolingüística, los estudiantes no emplean estos conocimientos para el diagnóstico, en consecuencia presentan dificultades para determinar las causas neurobiológicas y neurocognitivas de los diferentes trastornos que estudian, lo que afecta directamente el tratamiento.

De manera general en el Plan de Estudio vigente (Plan E) existe un vacío en la formación inicial de los mencionados profesionales. Los conocimientos sobre neurociencias, en especial los que defienden la neuropsicología, neurolingüística y psicolingüística no son contemplados, lo que repercute de forma negativa en la preparación de estos estudiantes para su desempeño pre profesional, en el periodo de práctica laboral, dado que las técnicas para la exploración, resultan insuficientes para detectar las causas neurobiológicas del trastorno, con lo que se ve afectado luego el debido tratamiento logopédico.

Esta situación polémica exige que se profundice en la importancia que tiene para la sociedad, la preparación de los logopedas que desde la formación, significa encontrar solución a los vacíos teóricos y prácticos que se evidencian hasta el momento. Se revela una contradicción entre las necesidades profesionales de los estudiantes de la carrera Logopedia y el contenido curricular de su formación. Evidenciado en:

- ✓ Insuficiencia curricular en la carrera de Logopedia que no contempla suficientes contenidos de neuropsicología y neurolingüística en la formación inicial.

- ✓ Los estudiantes de Logopedia en su formación inicial muestran carencias de conocimientos neuropsicológicos importantes para su profesión.

- ✓ La práctica pre-profesional del logopeda se ve afectada, en este sentido, en su función diagnóstica y atencional.

Dichas insuficiencias dan lugar al siguiente **problema de investigación**:

Insuficiencias formativas de los estudiantes de Logopedia en relación con los conocimientos de neurociencias que limitan su desempeño pre-profesional.

El problema de la investigación se localiza en el **objeto**: Formación inicial académica de los estudiantes de Logopedia; para tratar de coadyuvar a la solución se propone como **objetivo**: Diseñar un programa de asignatura con contenidos de neuropsicología y neurolingüística que contribuya al desempeño pre-profesional del Logopeda; en el cual se precisa como **campo de acción**: conocimientos de neuropsicología y neurolingüística.

Se propone como **tema** de investigación: Programa de asignatura: Neuropsicología cognitiva del lenguaje y neurolingüística.

En tal sentido se **defiende la idea** de que programa de asignatura que desarrolle contenidos de neuropsicología y neurolingüística tomando en cuenta las exigencias de la práctica pre-profesional y el vacío curricular existente, contribuye al perfeccionamiento de la formación académica de los estudiantes de Logopedia.

Tareas científicas:

- 1. Diagnosticar el desempeño pre-profesional de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Logopedia.

- 2. Fundamentar teórica y metodológicamente el material docente propuesto.

- 3. Elaborar el material docente Programa de la asignatura Neuropsicología y neurolingüística para estudiantes de Logopedia.

- 4. Valorar mediante criterios de expertos la propuesta teórico -metodológica del Programa de Asignatura Neuropsicología Cognitiva del lenguaje y Neurolingüística.

Métodos teóricos:

- Inducción – Deducción: para establecer generalizaciones concretas acerca de los diferentes aspectos del proceso investigativo.
- Modelación: en el diseño del programa de asignatura sobre aspectos de la neuropsicología del lenguaje.
- Hermenéutico: para la interpretación y comprensión de toda la información obtenida y procesada.
- Sistémico: Transcurrió durante todo la investigación proporcionando unidad y coherencia. Se manifestó de manera singular en la estructuración del programa de asignatura propuesto.

Métodos empíricos:

- Observación a actividades de atención logopédica (6 estudiantes en dos subgrupos, uno círculo infantil, otro, escuela primaria)
- Entrevista a logopedas con experiencia para determinar los conocimientos y habilidades de los estudiantes durante el diagnóstico y la atención
- Entrevista a profesores para conocer su opinión acerca de la factibilidad de un programa que aborde contenidos de neurociencias.
- Encuesta a padres para conocer el grado de satisfacción que poseen acerca del tratamiento que sus hijos reciben de los estudiantes
- Análisis de documentos para determinar si existen carencias curriculares que justifiquen un nuevo programa.
- Consulta a expertos para conocer los criterios de profesionales con experiencia y dominio de la materia que se investiga en relación con la factibilidad y aplicabilidad.

Para este estudio se seleccionó como *población* un total de 35 personas. De ellos 6 estudiantes del 4to año de la Carrera Educación Especial, en dos subgrupos teniendo en cuenta el lugar en el que realizaron la práctica laboral, un subgrupo en Circulo Infantil y el segundo subgrupo en las Escuelas del Lenguaje. Se entrevistaron a 4 profesores de la carrera, la selección se realizó a partir del cargo que ocupan, es decir; Jefe de Carrera, Jefe de la Disciplina Principal Integradora, Jefe de la Disciplina Logopedia, Profesor Principal de Año Académico del 3er año de la carrera donde se propone insertar la asignatura. Se seleccionaron 2 logopedas teniendo en cuenta que son los especialistas que tutoran a los estudiantes escogidos en las instituciones. La población además la conforman 6 familias de niños que reciben tratamiento logopédico por nuestros estudiantes. La validación de la propuesta se realizó con la participación de 17 jueces expertos.

La *Novedad* radica en la inclusión de un programa de asignatura que desde el currículo de la carrera, supere el enfoque tecnicista en el diagnóstico y tratamiento logopédico, avanzando hacia una interpretación neurocientífica que profundiza en las causas neurobiológica y neuropsicológicas de los trastornos del lenguaje, con lo que los estudiantes podrán desempeñarse con mayor efectividad en su práctica profesional.

El *Aporte* de la investigación lo constituye el programa de asignatura con contenidos de neuropsicología y neurolingüística para el perfeccionamiento de la práctica pre profesional de los estudiantes de Logopedia.

La *Significación práctica y Actualidad*: Está dada en el logro por parte de los estudiantes de Logopedia de conocimientos neurocientíficos que les permita el desarrollo de habilidades profesionales para dirigir adecuadamente los procesos de diagnóstico y tratamiento logopédico a niños y niñas con trastornos del lenguaje y la comunicación, con lo que puedan desempeñarse adecuadamente en su práctica pre profesional.

1. DIAGNÓSTICO DEL DESEMPEÑO PRE-PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LOGOPEDIA.

Indicadores para el diagnóstico

- ✓ Conocimientos neurocientíficos que poseen los estudiantes para diagnosticar y ofrecer tratamiento logopédico.
- ✓ Cómo se concibe en los documentos normativos la preparación neurocientífica de los estudiantes de Logopedia.

Unidades de análisis

- Estudiantes del cuarto año de la Lic. en Logopedia.
- Documentos normativos de la carrera Licenciatura en Educación Logopedia.

Técnicas aplicadas

- Observación a actividades de atención logopédica (6 estudiantes en dos subgrupos, uno círculo infantil, otro, escuela primaria)
- Entrevista a logopedas con experiencia para determinar los conocimientos y habilidades de los estudiantes durante el diagnóstico y la atención
- Entrevista a profesores para conocer su opinión acerca de la factibilidad de un programa que aborde contenidos de neurociencias.
- Encuesta a padres para conocer el grado de satisfacción que poseen acerca del tratamiento que sus hijos reciben de los estudiantes
- Análisis de documentos para determinar si existen carencias curriculares que justifiquen un nuevo programa.
- Consulta a expertos para conocer los criterios de profesionales con experiencia y dominio de la materia que se investiga en relación con la factibilidad y aplicabilidad.

Resultado de la observación

En el 90% de los estudiantes se pudo constatar el desarrollo de las habilidades pedagógicas para organizar la clase logopédica en correspondencia con el diagnóstico

identificado. Los ejercicios propuestos se relacionan con el trastorno identificado en función con la corrección o la compensación de dicho trastorno. En tal sentido el 10% de los estudiantes presentaron dificultades en la preparación de la clase, en función del diagnóstico, pues no se corresponden los ejercicios, con el trastorno del lenguaje a tratar, ya que emplean ejercicios al azar, sin tener en cuenta su pertinencia en relación con las características del trastorno que presenta cada niño.

En la relación objetivo – tratamiento, el 75% tuvo en cuenta que el objetivo de la clase logopédica se correspondiera con el posible trastorno a corregir o compensar, lo que no tiene que ver que el diagnóstico sea certero. Solo el 25% no logró este indicador.

En el diagnóstico, el 90% de los estudiantes presenta dificultades para la exploración de los contenidos psicológicos como procesos cognitivos o afectivos, lo que da cuenta de las limitaciones pre-profesionales para concebir un diagnóstico integral de cada niño o niña. Solo el 10% tienen en cuenta estos aspectos, logrando determinar la relación del lenguaje con otros procesos y en función de ello, realizar el tratamiento.

El 100% de los estudiantes muestran carencias en la creatividad profesional ejecutando ejercicios tradicionales para la exploración y el tratamiento logopédico, basados sólo en la búsqueda y tratamiento a los trastornos del lenguaje en sus diferentes niveles.

Estos instrumentos en alguna medida tienen en cuenta la relación del lenguaje con los procesos psíquicos, sin embargo, los estudiantes presentan dificultades para emplear dicha relación, por lo que los medios de enseñanza que emplean durante la clase estimulan los procesos psíquicos solo de manera indirecta, ya que su empleo no está destinado a dicha estimulación, sino al tratamiento para los trastornos del lenguaje.

Resultados de la entrevista a docentes.

La entrevista aplicada a 4 profesores de la carrera Logopedia aportó valiosos criterios sobre la importancia de la neuropsicología en la formación inicial del logopeda. En esta se constató que:

En el indicador relacionado con los conocimientos que alcanzan los estudiantes en neurociencias durante su formación, el 100% refirió que existen programas de

asignaturas como Anatomía y Fisiología Humana, Logopedia y Psicología que contemplan estos contenidos, aunque reconocen que son insuficientes para la formación del logopeda dada la importancia para su desempeño profesional y sobre todo en relación a su experiencia en el trabajo con los estudiantes de años terminales cuando realizan la práctica pre-profesional , etapa en la que se presentan deficiencias, según ellos, para realizar un diagnóstico certero y en consecuencia un adecuado tratamiento.

El 75% de los profesores refieren que el estudiante necesita instrumentos de exploración neuropsicológica que complemente el diagnóstico logopédico que le permitan desarrollar adecuadamente el diagnóstico integral. Estas limitaciones cognitivas, consideran los entrevistados, influyen negativamente a la hora de ofrecer tratamientos que incluyan actividades para la estimulación neuropsicológica de los niños con los que practica. El resto de los profesores considera como complementarios estos conocimientos, lo cual explica las actuales insuficiencias en los estudiantes.

El 50% de los profesores plantean que los estudiantes poseen habilidades para diagnosticar, modelar y dirigir los trastornos del lenguaje, el habla o la voz, considerando este aspecto como logrado. Sin embargo el 50% restantes plantean que no siempre desde el punto de vista metodológico se orienta a los estudiantes, desde la clase, de esa manera, teniendo este indicador como poco logrado.

Con relación a su opinión sobre las dificultades que presentan los estudiantes, el 75%, considera que están en la caracterización y diagnóstico en sentido general, ya que no logran integrar en la práctica pre-profesional todo el contenido que reciben en su formación inicial, lo cual se refleja en dificultades para registrar la información, escribir y exponer el diagnóstico de manera que sea explicativo y personalizado, dificultad que se recoge también en los informes de validación de la carrera.

El 100% reconoce que los estudiantes de Logopedia no reciben los conocimientos básicos en neuropsicología para la atención a los trastornos del lenguaje en sus diferentes niveles. De los trastornos conocen su definición, métodos para abordarlos, algunos refieren que las bases fisiológicas, pero no neuropsicológica y su relación con

los trastornos. Es necesario un mejor equilibrio teórico–práctico y un mejor vínculo de la labor médico–pedagógica para integrar estos conocimientos, desde el diagnóstico para dirigir el tratamiento integral.

Plantean que, en su práctica laboral, los estudiantes interactúan más con los trastornos del habla y el lenguaje en este orden, por la preferencia que existe de ser atendidos por el perfil médico, debido a su base clínica, reflejando en menor medida también, la falta de preparación desde el punto de vista metodológico, de algunos logopedas en ejercicio y de los propios docentes universitarios, lo que ha contribuido a que se pierda la continuidad en la ejercitación para la corrección y/o compensación de los trastornos que luego encuentran los estudiantes en la práctica pre-profesional.

Igualmente, todos coinciden en que están preparados teórica– metodológicamente en contenidos de logopedia, pero no en neuropsicología. Afirman saber escasamente de aspectos de Anatomía, solo los que trabajan tradicionalmente en asignaturas de la carrera.

Todos los profesores entrevistados le confieren vital importancia a un programa para la formación inicial del logopeda que aborde contenidos de neuropsicología para contribuir al desarrollo de conocimientos y habilidades pedagógicas profesionales.

Resultados de la entrevista a los logopedas

La entrevista realizada a 2 logopedas aportó los siguientes resultados:

Con relación al primer indicador sobre su criterio a cerca de la formación inicial de los estudiantes que recibe en su gabinete el 50% refiere que poseen una buena formación en el sentido de habilidades comunicativas, conocimientos, valores y aspectos éticos. También coinciden en que la principal problemática a la que se enfrentan es en el diagnóstico, en el proceso de buscar las causas y emplear los instrumentos correctos para llevar a cabo un diagnóstico integral.

El 50% refiere que la formación de los estudiantes es regular, porque poseen escasos conocimientos, acerca de los trastornos del lenguaje y su tratamiento.

El 50% consideró que los contenidos más importantes para un logopeda son los conocimientos de Logopedia. Uno de ellos considera que de Logopedia y Psicología agregando que los más importantes conocimientos son los de Anatomía.

El 100% refiere que los estudiantes desconocen patologías desde el punto de vista médico lo que les dificulta en el ámbito escolar ofrecer el tratamiento. No tienen en cuenta aspectos de neuropsicología y anatomía para el diagnóstico y tratamiento, por lo que no se proponen estimular desde el tratamiento logopédico, los procesos psíquicos.

Ambas consideran como causa de estas dificultades el poco vínculo con el área de salud, la poca interacción de los estudiantes con algunos trastornos, la preparación metodológica con relación al trabajo con las habilidades y su estructura interna en caso de la atención a los trastornos de voz en particular para la disfonía, a pesar de la incidencia del trastorno.

Reconocen, además, que las mayores dificultades en relación con el diagnóstico están en identificar la causa, la manifestación y la clasificación; con relación a modelar y dirigir, se refieren a las acciones para la respiración, el reajuste funcional y las cualidades de la voz.

El 100% de los logopedas señaló como conocimientos básicos que el logopeda debe dominar la Psicología, el 50% consideró la Neuropsicología y la Neurolingüística, además de la psicología. En cuanto a la Anatomía Patológica, no consideraron conocimiento básico para un logopeda.

El 50% consideró necesario los conocimientos de neurociencias, específicamente de Neuropsicología y Neurolingüística, aunque argumentó su criterio de manera básica como que conocer sobre ello les ayuda a entender las bases fisiológicas del lenguaje. Esto da cuenta que existe un nivel de conocimiento escaso sobre esta ciencia.

Para el 100% de las entrevistadas desconocen de la existencia documentos normativos que garanticen la preparación de los estudiantes desde el gabinete escolar.

Resultados de la entrevista a familiares

Se entrevistaron 6 familiares de niños que reciben atención logopédica. De ellos, el 90% de los padres poseen buen criterio acerca de la preparación de los estudiantes universitarios. Refieren que pesar de su escasa experiencia despuntan con mucha responsabilidad y consideran que: "*hay que apoyarlos en su formación y depositarles confianza a las nuevas generaciones que con ayuda del logopeda de la institución logran ser bastantes certeros en el diagnóstico y tratamiento".*

El 33% refiere que a pesar de que los niños están diagnosticados y se les brinda tratamiento en la escuela y en la casa, donde se aplican los ejercicios orientados por el logopeda, el niño no tiene notables mejorarías.

El 50% de los padres refieren cumplir con las actividades que el logopeda, estudiante universitario, le orienta al niño. Se muestran preocupados porque los tratamientos, se repiten en casa y no observan importantes mejorías.

El 66,6 de los padres no refiere haber observado alguna manifestación de rechazo por parte de su hijo (a) hacia el tratamiento logopédico, por lo contrario, refieren que los niños se sienten motivados con los ejercicios y los juegos que emplean para el tratamiento. Sin embargo, el 33.4 % sí plantea que sus hijos en algún momento rechazan los ejercicios en casa y el tratamiento de la logopeda.

Resultados del análisis de contenido

En el análisis de contenido se estudiaron documentos normativos que contienen las habilidades y conocimientos que deben adquirir y desarrollar los estudiantes durante su formación inicial; que incluyen modelos del profesional, planes de estudio, programas de disciplinas y asignaturas.

Se partió en el análisis desde los planes de estudio A, con la iniciación de la carrera en la especialización de Logopedia, después la introducción del plan C donde desaparece la carrera, las modificaciones y su reapertura hasta llegar al plan D y E vigentes con sus modelos del profesional. El referido análisis permitió obtener datos de interés relacionados con el tema que se investiga.

En el plan A no existía un modelo del profesional pero sí un documento que contenía la caracterización de la carrera con sus objetivos en función de habilidades y contenidos a desarrollar, las asignaturas se estructuraba por ciclos, el tratamiento al contenido de los trastornos de voz formaba parte de la asignatura de Logopedia y se complementaba con otras como Anatomía de los órganos de la audición y el lenguaje, cultivo y desarrollo de la voz, Fundamentos neuropsicológicos del lenguaje, Psicología del lenguaje y Educación rítmica con orientación logopédica.

En este plan se evidencia la presencia de una asignatura que abordaba contenidos de Fundamentos neuropsicológicos del lenguaje y Psicología del lenguaje, por lo que el logopeda formado en este plan de estudio adquirió conocimientos sobre la neuropsicología y su relación con la Logopedia.

El plan C se diseñó con un perfil amplio donde la Logopedia pasó a ser una disciplina como parte del Licenciado en Defectología. Este plan de estudio fue objeto de diversas modificaciones hasta llegar a la universalización. Un momento importante es la reapertura de la carrera de Logopedia, donde las asignaturas se estructuran por módulos, la asignatura de Logopedia, Fundamentos de Anatomía y Fisiología Humanas, Educación de la voz y la dicción, Psicología, Didáctica y Talleres profesionales. No se precisan contenidos de neuropsicología en ninguna de las asignaturas, por lo que existe un vacío en la formación inicial desde el conocimiento en neuropsicología.

La concepción del plan D tiene un modelo del profesional que declara los problemas profesionales que debe enfrentar el logopeda, destacándose entre otros el diagnóstico y caracterización de niños, adolescentes, jóvenes y adultos de la educación regular y especial, del grupo, del entorno familiar y comunitario donde se desenvuelven, el diseño y rediseño de las estrategias logopédicas personalizadas.

La disciplina Logopedia se distribuye en seis asignaturas para tratar los diferentes trastornos en virtud del desarrollo de habilidades profesionales, a la vez que se complementa con otras asignaturas como Voz y Dicción, Fonética y Fonología

Española, Anatomía y Fisiología Humanas, Pedagogía, Psicología y Didáctica, además de los cursos propios y optativos.

La disciplina Formación Laboral Investigativa, permite la vinculación de los componentes académico, laboral, investigativo y extensionista. De manera general este plan de estudio contiene los objetivos a desarrollar durante la carrera y en cada uno de los años, donde de manera implícita están encaminados al diagnóstico, la modelación y dirección del trabajo logopédico, pero no se declara como problema profesional y habilidades a desarrollar la exploración neurosicológica como punto de partida para el diagnóstico y tratamiento.

El Plan E está concebido con una integración curricular e interdisciplinaria en todo el universo de la Educación de la Primera Infancia, desde el modelo del profesional, el cual permite al estudiante conocer el universo de los educandos preescolares y escolares, con o sin trastornos del lenguaje y la comunicación, con necesidades educativas especiales asociados o no a la discapacidad, así como el entorno familiar y comunitario en que se desenvuelven y las relaciones de comunicación que se establecen entre estas agencias y agentes educativas.

A diferencia del plan anterior en este modelo del profesional, aparecen declaras las habilidades diagnosticar, dirigir, investigar y comunicar, se precisan mejor las funciones y tareas del logopeda, resaltando el papel de orientación a la familia y el rol que desempeña el logopeda en la comunidad. La disciplina de Logopedia en este plan de estudios igualmente es privilegiada con mayor cantidad de horas. En este plan de estudio el estudiante cuenta con una formación más organizada en cuanto a las disciplinas y los contenidos desde los programas de asignatura, el caso es que sigue faltando la vinculación de contenidos de neuropsicología en la formación inicial del estudiante, ya que son contenidos básicos para entender las bases fisiológicas del lenguaje, la relación con otros procesos psíquicos y como ello se integra para la producción del lenguaje. Como carrera de corte pedagógico se ve limitado el campo de acción de los estudiantes en la práctica pre profesional, por lo que no visualizan estos contenidos en casos de la vida cotidiana.

El Plan E está concebido con una integración curricular e interdisciplinaria en todo el universo de la Educación de la Primera Infancia, desde el modelo del profesional, el cual le permite al estudiante conocer el universo de los educandos preescolares y escolares, con o sin trastornos del lenguaje y la comunicación, con necesidades educativas especiales asociados o no a la discapacidad, así como el entorno familiar y comunitario en que se desenvuelven y las relaciones de comunicación que se establecen entre estas agencias y agentes educativas.

A diferencia del plan anterior en este modelo del profesional, aparecen declaradas las habilidades diagnosticar, dirigir, investigar y comunicar, se precisan mejor las funciones y tareas del logopeda, resaltando el papel de orientación a la familia y sobretodo, el rol que desempeña el logopeda en la comunidad. La disciplina de Logopedia en este plan de estudios igualmente es privilegiada con mayor cantidad de horas.

En este plan de estudio el estudiante cuenta con una formación más organizada en cuanto a las disciplinas y los contenidos desde los programas de asignatura, el caso es que sigue faltando la vinculación de contenidos de neuropsicología en la formación inicial de los estudiantes, ya que son contenidos básicos para entender las bases fisiológicas del lenguaje, la relación con otros procesos psíquicos y como ello se integra para la producción del lenguaje. Como carrera de corte pedagógico se ve limitado el campo de acción de los estudiantes en la práctica pre profesional, por lo que no visualizan estos contenidos en casos de la vida cotidiana.

El soporte bibliográfico de la carrera, garantiza la asimilación de los aspectos teóricos relacionados con las diferentes asignaturas. No cuenta con bibliografía que aborde la neuropsicología y su relación con la logopedia, tampoco con instrumentos de evaluación neuropsicológica que permiten al logopeda un diagnóstico y tratamiento integral.

La información recopilada de los informes de validación de la carrera y los exámenes integradores realizados reflejan que los estudiantes tienen dificultades con la caracterización de los niños con los que trabajan desde el punto de vista psicológico, y con ello hago referencia a los procesos afectivos, cognitivos.

Según dicho informe no siempre logran caracterizar adecuadamente a los niños según su trastorno, teniendo en cuenta estos aspectos. Aunque son contenidos que se trabajan en la asignatura de psicología el estudiante no logra visualizarlos en los ejercicios integradores. Desde la anatomía y la logopedia no se trabajan contenidos de neuropsicología, aunque esta última lo tiene contemplado en su sistema de contenidos.

Las mayores dificultades se revelan en la habilidad de modelar y dirigir, por lo que demuestran algunos ejercicios. Las mayores dificultades se presentan en la integración de los contenidos que reciben, desde las diferentes asignaturas.

Principales resultados del diagnóstico

El diagnóstico inicial realizado para precisar las causas del problema de la investigación, permitió establecer las principales dificultades de los estudiantes, las cuales se concretan en la necesidad de concebir un programa de asignatura que aborde contenidos de neuropsicología y neurolingüística para la formación inicial del logopeda, de manera que se observe un desarrollo cognitivo y procedimental en los estudiantes en su preparación que cumpla con las exigencias de la profesión

La interpretación de los métodos de investigación aplicados durante el proceso de diagnóstico, permitió determinar que asignaturas del currículo como Logopedia, Psicología, Anatomía y Fisiología Humana, de singular importancia para la formación del logopeda, abordan algunos contenidos de neuropsicología y neurolingüística que resultan insuficientes para la formación de este profesional, lo que se pudo constatar al indagar el desempeño en la práctica pre profesional de los estudiantes, quienes presentaron dificultades para incluir técnicas de exploración neuropsicológica, vitales para el diagnóstico y posterior tratamiento logopédico a los niños.

La influencia en las entidades laborales de base resulta limitada por las carencias formativas en neuropsicología y neurolingüística de los tutores.

Los estudiantes conocen elementos de los métodos y procedimientos para formular el diagnóstico logopédico, pero en la práctica pre-profesional lo desarrollan de forma simple, poco explicativa, no personalizada, debido a que aplican conocimientos

fragmentados, que limitan la comprensión integral del funcionamiento neurológico para el lenguaje. No logran la integración de elementos como causa, clasificación, síntomas y tratamientos novedosos a los trastornos del lenguaje.

La práctica pre-profesional garantiza, mediante los contenidos y tareas docentes, la preparación de los estudiantes para la atención logopédica, sin embargo, los escasos conocimientos que estos poseen, no les permiten implementar acciones para la estimulación neuropsicológica y neurolingüística de forma diferenciada, lo cual dificulta la efectividad del tratamiento ofrecido a los niños.

2.- CARACTERIZACIÓN DE LOS REFERENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. La formación inicial del logopeda.

El análisis del término *Formación* se remonta a los enciclopedistas franceses del siglo XVIII, quienes concuerdan en considerarla una teoría de la igualdad de capacidades enfatizando en la instrucción y la cultura; más tarde, el neohumanismo se refiere a la necesidad de educar para aprender a vivir, de manera que, si formar es dar forma, se considera que la formación sea un proceso que integra, crea y transforma.

Desde lo docente, autores como Addine, F. (2003); Labarrere, G. (2004) refieren que es un proceso contextualizado, consideran que la formación es el resultado de actividades organizadas de manera sistemática y coherente, que permiten actuar al sujeto de forma consciente y creadora, criterio que se asume por el carácter integrador del proceso formativo del logopeda.

El proceso de formación de profesionales, según Gatell, A. (2013), tiene un carácter esencialmente social y no puede quedar a la espontaneidad o la empírea de quienes intervienen en él y mucho menos de quienes lo dirigen, puesto que se desarrolla como un sistema y exige ser científicamente estudiado para incidir en su perfeccionamiento de manera eficiente y eficaz. Criterio que es compartido por autores como: Miranda, T. (2011), Valera, 2012; Bermúdez y Pérez, (2012); Herrán, Pérez y Torres, (2012), Paz, I; Rodríguez, Z; Parada A. (2016), Piñón, J. (2018), Bolaños, Y; Paz, I; Cortón, B. (2018)

El concepto de formación integral, es entendido en la educación superior cubana de la manera siguiente: La formación integral de los estudiantes universitarios debe dar como resultado graduados con un sólido desarrollo político desde los fundamentos de la ideología de la Revolución Cubana; dotados de una amplia cultura científica, ética, jurídica, humanista, económica y ambiental; comprometidos y preparados para defender la patria socialista y las causas justas de la humanidad, con argumentos propios y competentes para el desempeño profesional. Cardoza, E. (2020) referenciarlo en la bibliografía

La formación inicial ha sido objeto de estudio de números investigadores, como (García, 2001; Parra, 2002; Ferrer, 2003 y Chirino, 2003).

Sin pretender hacer un estudio de este fenómeno, es importante tener en cuenta algunos criterios de autores como Parra, (2001) y Chirino, (2003) quienes consideran la formación inicial como primera instancia de la profesión donde el desarrollo de habilidades ocupa un lugar importante.

Según Parra, (2001), es el ¨proceso en que el estudiante gradualmente comienza a desarrollar las habilidades inherentes a su profesión, a partir de la relación dinámica que establece con los componentes teóricos y prácticos de la misma¨ y para Chirino, (2002), es entendida como "el proceso de apropiación de conocimientos, habilidades, valores y métodos de trabajo pedagógico que prepara al estudiante para el ejercicio de las funciones profesionales pedagógicas, y se expresa mediante el modo de actuación profesional que va desarrollando a lo largo de la carrera".

Se considera que ambos criterios son válidos para esta investigación al considerar la formación inicial como el primer momento de acercamiento de los estudiantes a los contenidos esenciales de las diferentes disciplinas que tributan al desarrollo de habilidades para su labor profesional, porque además relaciona los componentes teóricos y prácticos, con lo actitudinal, lo cual hoy más que nunca requiere de una visión integradora.

En tal sentido, la carrera Licenciatura en Educación, Logopedia, tiene como objetivo básico formar maestros especializados en la atención integral al desarrollo del lenguaje y la comunicación en alumnos de los diferentes niveles del sistema nacional de educación, fundamentalmente desde las primeras edades (educaciones Preescolar y Primaria) para atender las situaciones relacionadas con los trastornos del lenguaje, el habla y la voz.

La importante labor que estos profesionales desempeñan en las instituciones educativas no puede concebirse circunscripta solo al trabajo con las dificultades y trastornos en la comunicación y el lenguaje, tanto oral como escrito, sino en su activa

influencia instructiva, educativa, correctiva y desarrolladora por el perfeccionamiento integral de los planos o niveles de la lengua y el enriquecimiento de la cultura idiomática de todos los educandos e incluso de los docentes y otros especialistas que laboran en la institución, lo que, sin dudas, tendrá una notable influencia positiva en la cultural general integral, en el desarrollo del pensamiento y en los resultados del aprendizaje.

Las funciones esenciales del maestro logopeda (Plan de estudio E. 2016) pueden expresarse de manera resumida en las siguientes: Función de diagnóstico y exploración relacionada con la identificación de potencialidades y necesidades educativas, fundamentalmente en el área del lenguaje y de la comunicación.

Función orientadora, que comprende, la información y la orientación para contribuir a labor preventiva, la instrucción y la coordinación de influencias, exigencias y acciones educativas, dirigidas a la familia, docentes, otros profesionales y a los propios educandos, relacionada esencialmente la corrección, desarrollo y enriquecimiento del lenguaje y las habilidades comunicativas.

Función instructiva, educativa, correctivo- desarrolladora, que comprende el tratamiento a las dificultades o trastornos verbovocales y de la comunicación oral y escrita (intervención logopédica en el más amplio sentido): acciones preventivas para evitar el surgimiento o agravamiento de dificultades o trastornos verbovocales, y de la comunicación; instauración, ejercitación y automatización de fonemas, precisión de la pronunciación, estrategias para la solución de dificultades o trastornos en la lectoescritura, caligrafía, ortografía, trabajo con el vocabulario y estructuras gramaticales; habilidades comunicativas en general, estrategias multidisciplinarias para atención a dificultades de aprendizaje

Función docente, relacionada con charlas educativas y talleres metodológicos para la preparación integral del claustro, labor de la tutoría con estudiantes de carreras pedagógicas que se forman en las entidades laborales de base y docencia en los centros universitarios municipales.

Función investigativa: exploración y diagnóstico integral de las capacidades y habilidades comunicativas y del grado de dominio de la lengua materna a los alumnos, colectivo pedagógico y otros especialistas de la escuela; estudio de incidencias de los trastornos y dificultades verbovocales y sus causas y búsqueda de estrategias y recursos efectivos para su solución.

Fernández, G. define la atención logopédica como “proceso especializado dirigido por el logopeda, de carácter integral, multi e interdisciplinario que se desarrolla preferentemente, en los diferentes contextos educativos, preescolares y escolares, la familia y la comunidad. Se inicia con el diagnóstico y utiliza como vía el método integral de atención logopédica, las ayudas, recursos y apoyos que propician la prevención, la estimulación y el desarrollo del lenguaje, la corrección y la compensación de los trastornos del lenguaje y de la comunicación, el desarrollo multilateral del niño, la evaluación y seguimiento de los resultados”.

El trastorno del lenguaje es un problema de la comunicación con alta incidencia y prevalencia en la población escolar, el cual afecta negativamente el desempeño académico, y el desarrollo de social y afectivo de los niños que lo padecen. Se afectan funciones ejecutivas, además de componentes del lenguaje: fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático (Lepe, N 2018).

Los estudios sobre este trastorno se han agrupado en dos posturas: un enfoque lingüístico (Patterson y Gardner, 2011) que consideran un problema específico de los componentes del lenguaje, el segundo enfoque es el de procesamiento de la información (Bermeosolo, 2012 y otros) que lo consideran un problema general de la cognición, encontrándose afectados tanto los componentes lingüísticos como no lingüísticos (Mendoza, 2012).

Según el Manual de Diagnóstico (DSM-5) el trastorno del lenguaje se considera un problema de la comunicación que forma parte de los trastornos del Neurodesarrollo. Se define como un conjunto de dificultades persistentes tanto en la adquisición como en la producción del lenguaje, en sus distintas modalidades: hablado, escrito y signos.

Los antecedentes históricos relacionados con la formación inicial del logopeda en Cuba, se reflejan en los trabajos realizados por diferentes autores del área de salud y de educación como Cabanas, Álvarez y Méndez, (1945-2008) y Fernández y López (1980-2010); de los cuales se presenta una síntesis aportando algunas consideraciones de la autora en relación con desarrollo de habilidades pedagógicas profesionales para la atención a la disfonía.

La sistematización realizada, tuvo en cuenta los siguientes criterios: etapas y planes de estudio, modelos del profesional, enfoques asumidos, características generales de la formación inicial del logopeda atendiendo a los conocimientos de neuropsicología y neurolingüística que estudiantes los estudiantes reciben en su formación.

En la década del 60 comienza en Cuba la preparación de maestros graduados y bachilleres en Logopedia seguido por la formación de logopedas educacionales de nivel medio, como maestros terapeutas. En los años 70 se caracterizó por el perfeccionamiento del subsistema de Educación Especial y la formación en el extranjero, básicamente, en los países de Europa del Este de Licenciados en Defectología, en la actualidad Pedagogía Especial y sus diferentes ramas, entre ellas, la Logopedia con un enfoque clínico-psicopedagógico que abarca la prevención, educación, reeducación y rehabilitación del lenguaje oral y escrito en niños y jóvenes, sobre la base de los postulados de la escuela histórico-cultural de Vigotsky y sus seguidores.

En la década del 80 comienza la formación universitaria de maestros de Educación Especial, donde se estudiaban dos especialidades: Oligofrenopedagogía y Logopedia, en la modalidad de curso regular diurno, momento en que estaba vigente la generación de planes A en la Educación Superior del país y se trabajaba para introducir los planes B, por los cuales no transitó esta carrera por el poco tiempo que había transcurrido desde su apertura.

Es importante destacar que en el curso 1981 – 1982 unido al desarrollo de la Educación Especial en todo el país, se extendió paulatinamente la carrera a otros Institutos Superiores Pedagógicos del país, incluido el de Pinar del Río que fue el tercero de ellos,

lo que permitió el vuelco de la Educación Especial y en específico de la Logopedia; extendiendo los servicios logopédicos a las escuelas primarias.

El sistema de formación práctico laboral, vinculaba a los estudiantes a la escuela desde los primeros años, aunque fundamentalmente con actividades de observación, garantizando el vínculo más sistemático en el último año de la carrera. En correspondencia con las concepciones de la enseñanza relacionadas con el diagnóstico y la intervención, existía un marcado enfoque clínico-terapéutico en el tratamiento de los contenidos, centrado en el defecto más que en las posibilidades de desarrollo, pero con adecuada concepción de la atención individual y diferenciada y del trabajo correctivo-compensatorio.

En los primeros años de diseño y ejecución, fue menor el enfoque pedagógico en el tratamiento a los contenidos, lo cual se hacía más evidente por el predominio de las concepciones médicas, en relación con el objeto de estudio de la ciencia Logopedia en el país. Según las exigencias sociales y las concepciones de la enseñanza se formaba un profesional con perfil estrecho.

En la década del 90, la carrera de Defectología comienza a desarrollar los planes de estudio C, cuya trasformación esencial fue la ampliación de su perfil: formación integral del maestro de Educación Especial como una especialidad, sin las especializaciones que existían hasta ese momento y se amplía a 5 años de duración.

En esta etapa la estructura curricular es disciplinar con respeto a la lógica de la ciencia, donde la Logopedia de una especialidad pasó a ser una disciplina.

Aunque no existía la carrera se puede destacar que los enfoques asumidos son: ontogenético, de diagnóstico y terapéutico, hasta el 95, que se considera en vez de terapéutico, estimulador del desarrollo y que se realizan transformaciones en la concepción de asignaturas, lo que posibilitó que posteriormente la Logopedia se ampliara para abarcar otros trastornos de la comunicación. Los contenidos asumieron un mayor enfoque pedagógico.

Por la necesidad de tener un Logopeda en cada institución educativa y debido a la valiosa contribución de este profesional; en la década del 2000 se realizó un curso de preparación logopédica con estudiantes en formación de las carreras de Licenciatura en Educación Primaria, Preescolar y Especial (Resolución Ministerial 192/2004) en las universidades pedagógicas cubanas y posteriormente en el curso escolar 2007 – 2008 se vuelve abrir como carrera independiente la Licenciatura en Educación Logopedia.

En el curso escolar 2009 – 2010 el plan de estudio C de la carrera, en la modalidad de curso regular diurno fue objeto de nuevas modificaciones, en esta etapa el modelo del profesional es un documento que contiene los objetivos a lograr a nivel de carrera y de años y las áreas de integración de los contenidos, sin precisar los problemas profesionales y las habilidades pedagógico profesionales a desarrollar en los estudiantes.

Hubo un exceso de objetivos de carrera y por años que afecta su instrumentación y la coherente organización de todas las asignaturas. Los objetivos eran poco integrados y se pierde el carácter disciplinar, adoptando una estructura curricular modular; aunque se reconoce la integración de los componentes académico, investigativo y laboral, siendo este último el componente rector

En el curso 2010-2011 comienza un nuevo Plan de estudio (Plan D), el cual se está organizado en un currículo base, un currículo propio y un currículo optativo-electivo, con un modelo del profesional elaborado según las necesidades y exigencias del momento en la sociedad, donde se declara el objeto de trabajo, el modo y las esferas de actuación, el campo de acción y los problemas profesionales que debe enfrentar este profesional, así como sus funciones y tareas, objetivos generales en función de habilidades y por años, las cualidades y aspectos éticos a considerar.

Se retoma la concepción disciplinar durante los 5 años de la carrera, así como el enfoque sistémico, lo cual favorece un mejor trabajo metodológico entre la carrera, las disciplinas y los años académicos y las relaciones inter e interdisciplinarias, lo que permite la integración de los componentes académico, laboral, investigativo y extensionista, desde la disciplina principal integradora: Formación laboral investigativa,

que tiene características organizativas diferentes para cada año académico, consolidando los conocimientos teórico-prácticos.

El curso 2016-2017 a cinco años de validación del plan de estudios D, se implementa el Plan E que como el anterior, se organiza en currículo base, propio y optativo/electivo, con la diferencia de que tiene una duración de 4 años, por su concepción pondera la esencialidad, requiere de niveles altos de integración interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria, al integrar los contenidos de las diferentes asignaturas y disciplinas, potencia el dominio de una cultura informática, de independencia cognoscitiva y de implicación en los procesos extensionistas de la Universidad, de manera que el estudiante sea proactivo de su propio proceso formativo.

La formación laboral investigativa continúa siendo la disciplina integradora consolidando los componentes académico, laboral, investigativo y extensionista, lo cual favorece en desarrollo de habilidades, declaradas en el modelo del profesional tales como: diagnosticar, comunicar, dirigir e investigar. Un aspecto distintivo en este plan es la integración curricular en las carreras de la Educación Infantil donde se incluye Logopedia, lo cual contribuye a la realización de evaluaciones integradoras y prepara mejor al estudiante durante el pregrado, proyecta la preparación para el empleo y el posgrado.

Según este nuevo plan de proceso docente el logopeda debe estar preparado para atender a la diversidad en los diferentes contextos educativos. En particular, resulta relevante su papel protagónico en el trabajo preventivo mediante el diagnóstico, la orientación y el seguimiento a quienes presenten trastornos en el desarrollo del lenguaje y la comunicación, los que se encuentren en grupos de riesgo o transiten de la educación especial a la regular.

Por ello, debe constituir una prioridad la formación integral del logopeda, en la que pudiera valorarse la necesidad de incorporar contenidos que permitan los conocimientos necesarios de neuropsicología y neurolingüística encaminados a buscar posibles causas y vías novedosas para dirigir acciones correctivo-compensatorias y de

integración entre la familia y el resto de los agentes y agencias educativas que eleven la efectividad de su rol profesional.

2.1 Psicolingüística y Neurolingüística en la formación del logopeda.

La psicolingüística es una disciplina que trata de descubrir cómo se produce y se comprende el lenguaje por un lado y cómo se adquiere y se pierde el lenguaje por otro. Muestra, por tanto, interés por los procesos implicados en el uso del lenguaje, es por ello que sus conocimientos poseen vital importancia para la formación del logopeda.

- Estudia cómo se utiliza el lenguaje
- El uso de nuestros conocimientos
- La actuación: el conjunto de procedimientos por los cuales dicho conocimiento se aplica a la comprensión y producción de expresiones lingüísticas
- Se centra en los procesos de actuación que ponen en marcha el instinto lingüístico.

Sus objetivos son básicamente dos:

1. Análisis de las actividades de producción y comprensión del lenguaje.

2. Estudio de aspectos evolutivos y patológicos de la lengua.

Por su parte la lingüística estudia qué constituye el lenguaje, analizado como un elemento sistemático por:

- Las partes que componen el sistema se definen: Por sus relaciones de oposición (sintagmáticas) Por sus relaciones de distribución (paradigmáticas)
- Existen distintos niveles: desde el fonológico hasta el sintáctico.
- La competencia: conocimiento tácito que todo hablante posee de su propia lengua.
- La actuación: el conjunto de procedimientos por los cuales dicho conocimiento se aplica a la comprensión y producción de expresiones lingüísticas
- A través de teorías generales que explican los principios de las lenguas generales

- Se centra en los procesos de actuación que ponen en marcha el instinto lingüístico. :

Desde hace relativamente poco tiempo, podemos encontrar dentro de las aplicaciones de la lingüística con nuevas disciplinas, cada vez más difusas sus fronteras entre la Psicolingüística, la Neurolingüística y la Logopedia (Garayzábal y Otero, 2005). Dichas disciplinas comparten un mismo objeto de estudio, pues no existe objeto más complejo que el lenguaje, están relacionadas entre sí por estudiar, cada una desde su posición el lenguaje entendido como realidad neuropsicológica.

Se trata de mostrar aquellos aspectos en que ambas disciplinas mantienen puntos de vista divergentes. Estos son algunos ejemplos. En el campo de la comprensión, la unidad mínima acústica para la lingüística, la unidad mínima es el fonema, pero la psicolingüística ha demostrado que la unidad mínima que percibe el cerebro humano es la sílaba.

En el campo de la producción, el sujeto de estudio, para la lingüística es el hablante nativo ideal (una abstracción), mientras que para la psicolingüística es el hablante real. Igualmente, respecto a las incrustaciones, para la lingüística son teóricamente posibles cuatro incrustaciones de cuatro subordinadas distintas, pero de hecho sólo se encuentran en la lengua oral. Para la psicolingüística tal fenómeno no ocurre en la lengua corriente y para su análisis haría falta lápiz y papel.

En cuanto al objeto de estudio, referidos a los principios respecto al uso del lenguaje, la lingüística busca las formas más elegantes, formales y abstractas, pero la psicolingüística busca los principios de operatividad. Finalmente, respecto al método, la lingüística usa la intuición, pero la psicolingüística no admite tal principio.

La importancia de la lingüística aplicada tanto en el marco de la adquisición del lenguaje como de las alteraciones del habla y del lenguaje queda manifiesta en el hecho de que identifique, describa e interprete la conducta lingüística de una persona.

Por su parte la neurolingüística estudia como el cerebro hace posible el lenguaje, conocer los procesos y las estructuras que subyacen a la conducta verbal humana, con un

especial interés en la alteración patológica de la conducta lingüística. Esta ciencia avanza a pasos agigantados y confluyen en este campo investigadores de muchas áreas, no solo la Lingüística y la Neurología, sino también de la Logopedia y la Psicología.

La logopedia trata diferentes alteraciones del habla, del lenguaje, (oral y escrito) y de la comunicación en general (tanto en los procesos de producción como de comprensión) en niños y adultos (Luque y Hernández 2000) y se considera cuatro estadios en la práctica del logopeda: prevención, diagnóstico, corrección-compensación y tratamiento.

Ya analizado el objeto de estudio de la lingüística queda claro que aunque ambas disciplinas comparten el mismo objeto, las patologías del lenguaje, la distinción se hace más obvia cuando analizamos su metodología y los objetivos que persiguen. El objetivo de un lingüista nunca será la rehabilitación de un paciente, la terapia forma parte del trabajo del logopeda. Desde la lingüística se trata de analizar, describir, para poder, eso sí, ayudar a solventar el problema. Digamos que la lingüística proporciona las herramientas con las que trabaja el logopeda (Garayzábal y Otero, 2005)

2.2 Importancia de los conocimientos neurocientíficos para el logopeda.

El logopeda además de brindar tratamiento logopédico debe conocer las áreas del cerebro que intervienen en el lenguaje, así mismo la relación que se establece entre ellas y el papel de cada una en el desarrollo de este proceso.

Desde una perspectiva cognitiva se ha demostrado que existen funciones ejecutivas deficientes en niños que presentan este trastorno. Las funciones ejecutivas son entendidas como procesos cognitivos de alta complejidad que permiten la organización temporal tanto del comportamiento, como del lenguaje y el razonamiento (Fuster, 2008).

La Neurociencia es un abordaje multidisciplinar del estudio del sistema nervioso cuyo objetivo es unificar el conocimiento de los procesos neurobiológicos y psicobiológicos, después de que durante mucho tiempo el estudio de la mente y el cerebro se hayan mantenido como dos realidades diferentes. En buena medida este hecho se ha debido al predominio de los planteamientos dualistas, que impusieron la creencia de que ambas eran dos entidades cuantitativa y cualitativamente diferentes. Por este motivo, el estudio

del sistema nervioso y el de la mente humana fueron el objeto de estudio por parte de la biología y la filosofía de un modo separado.

Los prejuicios ya existentes en civilizaciones precristianas, asumiendo los planteamientos dualistas como verdad axiomática han prevalecido hasta fechas muy recientes, frenando el conocimiento de las relaciones mente-cerebro. Por fortuna, el rápido avance en el conocimiento del sistema nervioso experimentado a partir de la segunda mitad del siglo XX ha propiciado el definitivo acercamiento entre las diferentes disciplinas preocupadas por el estudio de la actividad del sistema nervioso.

La Neurociencia estudia el sistema nervioso desde un punto de vista multidisciplinario, mediante el aporte de diversas disciplinas como Biología, Neurología, Psicología, Química, Física, Farmacología, Genética o Informática. Dentro de esta nueva concepción de la mente humana, estas ciencias son necesarias para comprender las funciones nerviosas, especialmente las que son inherentes a la especie humana, es decir, las funciones mentales superiores.

Como afirma Kandel (1996), la Neurociencia surge con el objetivo de entrelazar los distintos estratos que conforman la realidad humana, desde la neurobiología molecular hasta la cognición, permitiendo que podamos entender qué nos hace ser lo que somos. Se puede definir la Neurociencia como el ámbito interdisciplinar que estudia diversos aspectos del sistema nervioso: anatomía, funcionamiento, patología, desarrollo, genética, farmacología y química, con el objetivo último de comprender en profundidad los procesos cognitivos y el comportamiento del ser humano (Mora y Sanguinetti, 1996).

Las primeras sociedades neurocientíficas surgen en Norteamérica a partir de los años 60 del siglo pasado y en la actualidad son una fructífera realidad en numerosos países. La primera sociedad neurocientífica existente fue la Society for Neuroscience, fundada en 1970 en los Estados Unidos. Posteriormente se han ido creando otras en muchos países, como la ENA (European Neuroscience Asociation) y la SEN (Sociedad Española de Neurociencia).

Las asociaciones neurocientíficas están constituidas por profesionales de muy diversa procedencia: neurobiólogos, bioquímicos, fisiólogos, farmacólogos, neuroanatomistas, psicólogos, físicos, químicos, matemáticos, neurocirujanos, psiquiatras o informáticos. La asociación neurocientífica con mayor número de miembros es la Asociación Americana de Neurociencia en los Estados Unidos, formada por más de 24.000 asociados, de los que el 16,1% son psicólogos, el 14,3% fisiólogos, el 12,5% farmacólogos y el 11,2% biólogos (Pinel, 2000).

Sorprende el hecho de que los profesionales procedentes de la Psicología tengan una representación cuantitativa tan importante, por lo que se puede pensar que definitivamente se está empezando a cerrar la brecha existente entre el conocimiento de la mente y el cerebro desde abordajes dualistas.

Por otra parte, la introducción de la neuroimagen funcional ha permitido por vez primera acceder al interior del cerebro en funcionamiento, observando las modificaciones que se producen en él durante la realización de un determinado proceso cognitivo, lo que ha contribuido muy activamente al acercamiento definitivo entre neurobiólogos y psicobiólogos.

Dentro del amplio marco de la Neurociencia existen dos orientaciones, conductuales y no conductuales, según su mayor énfasis en el estudio del sistema nervioso o en el del comportamiento. Las Neurociencias de orientación no conductual centran su interés en algún aspecto del sistema nervioso, prestando menor atención a los aspectos cognitivos y comportamentales.

Se incluyen aquí disciplinas como Neurobiología, Neuroanatomía, Neurología, Neurofisiología, Neurofarmacología o Neuroendocrinología. Las Neurociencias de orientación conductual, por su parte, se preocupan por relacionar el sistema nervioso con determinados aspectos de la conducta y los procesos cognitivos.

Se incluyen en este grupo: Psicobiología, Psicología Fisiológica, Psicofisiología, Psicofarmacología, Neuropsicología y más recientemente Neurociencia Cognitiva. La Neurociencia Cognitiva es el resultado de la creciente diversificación de las

Neurociencias conductuales y constituye un ejemplo de la fructífera colaboración entre neurobiólogos y psicobiólogos. Según Kandel la Neurociencia cognitiva es el resultado de la fusión entre Neurociencia y Psicología.

La cognición es el proceso de integración, transformación, codificación, almacenamiento y respuesta de los estímulos sensoriales. El objetivo de la Neurociencia Cognitiva es el estudio de los procesos mentales superiores, habitualmente denominados procesos cognitivos: pensamiento, lenguaje, memoria, atención, percepción y movimientos complejos.

Lo específico de la Neurociencia Cognitiva es el estudio de la cognición humana mediante técnicas no invasivas, recurriendo especialmente a la neuroimagen funcional del cerebro mientras se realiza una determinada actividad cognitiva. Por este motivo, recurre a las aportaciones de diversos especialistas como informáticos, expertos en ingeniería del conocimiento o psicólogos cognitivos. Los límites existentes entre Neurociencia Cognitiva, y otras Neurociencias conductuales como Neuropsicología o Psicología Fisiológica resultan difusos y difíciles de establecer.

El interés de la Neurociencia por el estudio de la cognición ha ido creciendo progresivamentete en los últimos años ya que, en última instancia, el único output del sistema nervioso siempre es la conducta. La incorporación de las ciencias de la conducta y especialmente de la ciencia cognitiva está permitiendo superar el vacío que tradicionalmente existía entre las dos orientaciones de la Neurociencia.

Ha sucedido que los neurobiólogos minimizaban la preocupación y el interés por el comportamiento y la actividad mental, mientras que los psicólogos estaban más interesados en el estudio de los procesos cognitivos, con frecuente desinterés por el sistema nervioso como último responsable del comportamiento humano. Gracias al desarrollo de la Neurociencia, con el valioso apoyo de la neuroimagen funcional empezamos a recorrer un camino conjunto que permitirá profundizar en la compleja realidad del ser humano sin prejuicios excluyentes.

La Neuropsicología es una Neurociencia que estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta tanto en sujetos sanos como en los que han sufrido algún tipo de daño cerebral (Kolb & Whishaw, 2002; Rains, 2003). Difiere de otras Neurociencias conductuales en su objeto de estudio, ya que se centra de modo específico en el conocimiento de las bases neurales de los procesos mentales complejos. Por esta razón los sujetos de estudio de la Neuropsicología son casi exclusivamente seres humanos y las conductas estudiadas son más específicas de nuestra especie como: pensamiento, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas y formas más complejas de motricidad y percepción. Sus principales características son:

- Estudia las funciones mentales superiores Se centra específicamente en el estudio de los procesos cognitivos superiores: pensamiento, lenguaje, memoria, funciones ejecutivas, percepción y motricidad. También estudia las consecuencias del funcionamiento cerebral sobre la conducta emocional.
- Carácter neurocientífico. La Neuropsicología es una neurociencia conductual que utiliza el método científico natural para el estudio del cerebro y lo hace mediante el procedimiento hipotético-deductivo o a través del método analítico-inductivo. Mediante el método hipotético-deductivo establece hipótesis que son refrendadas o refutadas mediante la realización de experimentos. A través del procedimiento analítico-inductivo realiza experimentos para poner a prueba la relación funcional entre variables controladas.
- Trata preferentemente de las manifestaciones del córtex cerebral asociativo Hay dos razones que justifican este hecho: en primer lugar, la corteza asociativa es la principal responsable de los procesos cognitivos superiores. En segundo término, ésta es una zona muy susceptible de resultar dañada, lo que puede afectar a los procesos cognitivos. Otras áreas del encéfalo como cuerpo calloso, tálamo, ganglios basales, amígdala, hipocampo o cerebelo también pueden tener implicaciones sobre la conducta, por lo que sus lesiones también pueden afectar a las funciones mentales superiores o a la regulación de la actividad emocional.

- Estudia las consecuencias del daño cerebral sobre los procesos cognitivos Existe una división entre Neuropsicología básica y Neuropsicología clínica. La Neuropsicología básica aborda el estudio de las relaciones entre la cognición y el cerebro en sujetos sanos y en cierta medida es claramente homologable a la Neurociencia cognitiva.

La Neuropsicología clínica estudia las consecuencias del daño cerebral sobre la conducta: trastornos del pensamiento, síndrome disejecutivo, afasias, amnesias, agnosias, apraxias y alteraciones neuroconductuales. La Neuropsicología clínica tiene un mayor peso que la Neuropsicología básica en la dedicación profesional de los neuropsicólogos, ya que en la mayoría de las ocasiones éstos centran su actividad en las personas con disfunciones cognitivas o trastornos de conducta en las que se sospecha que ha existido afectación del sistema nervioso central.

La división de Neuropsicología de la Asociación Americana de Psicología define al neuropsicólogo clínico como un psicólogo profesional que aplica criterios científicos para la evaluación e intervención, basándose en el estudio científico del comportamiento humano y relacionándolo con el funcionamiento normal y anormal del sistema nervioso central.

Utiliza modelos humanos La Neuropsicología humana coexiste junto a la Neuropsicología de otras especies de mamíferos, pero cada una tiene su propia especificidad. En primer lugar, existen dificultades deontológicas, ya que no es posible inducir lesiones experimentales del sistema nervioso en humanos, salvo en situaciones excepcionales en las que hay que recurrir a la Neurocirugía Terapéutica.

En segundo lugar, la cognición animal y humana no siempre son extrapolables, ya que los procesos cognitivos de la especie humana son cuantitativa y cualitativamente muy diferentes a las de cualquier otra. Una prueba es que la proporción y extensión de neocorteza en cualquier especie animal es muy inferior a la de los seres humanos.

La investigación psicofisiológica con modelos animales ha aportado valiosas informaciones sobre determinados procesos básicos del hombre, pero hay grandes

limitaciones a la hora de establecer generalizaciones excesivas, dado el gran diferencial cualitativo existente entre la actividad mental superior de la especie humana y la de cualquier otra especie animal.

Carácter interdisciplinar: En sus orígenes la Neuropsicología surgió como una nueva especialidad autónoma gracias a la convergencia y las aportaciones procedentes de disciplinas muy diferentes como neurología, biología, neurofisiología, neuroquímica, neurorradiología, medicina nuclear, psicología experimental, farmacología, fisiología y psicología cognitiva.

Además, su carácter interdisciplinar también se debe a que los neuropsicólogos ejercen su actividad dentro de un ámbito igualmente interdisciplinar en el que atienden el daño cerebral junto a otros profesionales como neurocirujanos, neurólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, terapeutas del lenguaje, psicólogos clínicos, trabajadores sociales y neuropsiquiatras

La neuropsicología ofrece al psicólogo cognitivo la posibilidad de verificar con individuos reales, lesionados cerebrales, las predicciones hechas desde sus modelos teóricos. Este encuentro entre ambas disciplinas supuso así un enriquecimiento mutuo. La neuropsicología va a poder ahora contribuir de modo importante a la verificación de los modelos procedentes de la psicología cognitiva. (Benedet. 2002)

2.3 Neuropsicología del lenguaje

En los últimos años se ha especulado mucho sobre la organización cerebral del lenguaje, y es evidente el dominio abrumador del lado izquierdo en la representación del habla, sobre todo en las personas diestras, aunque hay que considerar la posibilidad de que la representación del habla no esté siempre completamente lateralizada en un hemisferio. Estas especulaciones y otras similares son inferencias indirectas del estudio de un gran número de pacientes con lesiones cerebrales unilaterales.

Se encontraron también algunos casos de bilateralidad, pero nunca en diestros. Hasta ese momento se habló de dominancia del hemisferio izquierdo en la representación de los diferentes aspectos del lenguaje.

Es un hecho que las funciones del lenguaje en el ser humano dependen más de un hemisferio que de otro. Este hemisferio está encargado de la jerarquización y la simbolización y a menudo ha sido llamado el hemisferio dominante. Sin embargo, hoy en día está claro que el otro hemisferio no está simplemente menos desarrollado o nos es menos dominante, sino que tiene otras especializaciones, tales como las relaciones de espacios temporales o el reconocimiento de temas musicales.

A pesar de lo rudimentario del conocimiento sobre la ubicación de las funciones del lenguaje hay pruebas de que una región de la circunvolución temporal superior llamada área de Wernicke, en el hemisferio identificador, interviene en la comprensión visual y auditiva. El área de Broca, en el hemisferio cualificador, procesa la información que recibe del área de Wernicke, transformándola en un patrón detallado y coordinado para la vocalización, y luego proyecta ese patrón a la corteza motriz, la cual inicia los movimientos apropiados del aparato fonador para producir el habla. La circunvolución angular situada por detrás del área de Wernicke, al parecer procesa la información de las palabras leídas.

2.4 Necesidad de contenidos de Neuropsicología cognitiva del lenguaje y Neurolingüística en la formación profesional del logopeda.

Actualmente la carrera se encuentra transitando por el plan de estudio E en la que la formación inicial de los estudiantes es de 4 años. Este nuevo plan de estudio a diferencia de los anteriores es un total de 9 disciplinas: Marxismo Leninismo, Historia de Cuba. Preparación para la defensa, Educación Física, Formación Pedagógica General, Estudios Lingüísticos y literarios, Logopedia, Didácticas Particulares, Formación Laboral Investigativa.

La disciplina de Formación Pedagógica General forma parte de núcleo teórico común de todas las Carreras de Ciencias de la Educación. Los programas de asignatura que la integran son: anatomía y Fisiología Humana, Psicología (I, II, III) y Pedagogía.

En los Sistemas de conocimientos acerca de las bases anatomofisiológicas del desarrollo infantil encontramos la importancia del estudio de la anatomía y Fisiología del desarrollo para la labor del maestro. El enfoque preventivo, ontogenético, bioético y estimulador del desarrollo. Periodos sensitivos del desarrollo humano. El árbol genealógico. Patrones de herencia, trastornos más frecuentes. Principales avances de la genética y la biotecnología vinculadas con las discapacidades humanas y el talento. Procesos de crecimiento y desarrollo. Caracterización del desarrollo físico para el diagnóstico.

Bases morfofuncionales del control nervioso. Ontogénesis del sistema nervioso, métodos de estudio. Sistemas sensoriales. Sistemas somato-sensoriales. Trastornos más frecuentes. Los avances tecnológicos del proceso correctivo compensatorio. Sistemas motores del control nervioso: niveles funcionales del sistema motor somático. Trastornos más frecuentes. Bases biológicas de la psiquis: aprendizaje y memoria, la atención, el lenguaje y los procesos afectivos. Integración funcional de la corteza cerebral. Fundamentos biológicos de los trastornos del lenguaje, del retraso mental, el retardo en el desarrollo psíquico y los trastornos de la conducta. Plan de estudio E.

Estos son los contenidos de dicha asignatura que se relacionan en mayor medida con contenidos de neuropsicología, pero no lo aborda desde esta ciencia. Se utiliza retraso mental, ahora sustituido en los nuevos manuales diagnósticos por Discapacidad intelectual.

En la asignatura Psicología se abordan los sustentos psicológicos del desarrollo infantil, se imparten contenidos sobre la psicología como ciencia, objeto de estudio. Diferentes concepciones del desarrollo, principios, leyes y categorías del enfoque histórico cultural. Concepción de la personalidad, la actividad y la comunicación en la psicología dialéctico materialista. Estructura de la personalidad. Periodización del desarrollo de la personalidad.

Formaciones psicológicas complejas. Relación personalidad-sexualidad. El proceso de evaluación, diagnóstico y caracterización psicopedagógica. Métodos y técnicas de investigación psicológica para el aprendizaje y la estimulación. Condiciones favorecedoras y entorpecedoras del desarrollo de la personalidad, estimulación y orientación psicológica a algunas conductas en la edad preescolar, escolar y adolescencia. Actividad y comunicación para la labor del maestro, la mediación del adulto en el proceso de estimulación. Plan de estudio E.

Cuando se analizan los contenidos de ambas asignaturas (psicología y anatomía y fisiología humana) se evidencia la presencia de nodos de conocimientos en común, los cuales no se trabajan de manera conjunta entre ambas asignaturas. Se considera que la carrera debe trabajar desde la disciplina con la elaboración de ejercicios integradores para que el estudiante pueda integrar el conocimiento.

Las asignaturas deben realizar un trabajo metodológico dirigido a la organización del contenido. En cuanto a los contenidos necesarios de la neuropsicología para la formación inicial del logopeda no se están contenidos en los programas.

Por su parte la disciplina Logopedia forma parte del currículo base del Plan de Proceso Docente (PPD), considerada como una disciplina del ejercicio de la profesión en la carrera de logopedia. Esta toma como referente las bases conceptuales para el diseño de los documentos de los planes de estudio E. De ahí que asegure el dominio de los modos de actuación para la dirección del proceso de atención logopédica integral en el futuro profesional, en tanto contribuye a la adquisición de habilidades profesionales, según las exigencias del Modelo del profesional.

Como fundamentos de la disciplina asumen los postulados de la teoría socio-cultural de Vigotsky y sus seguidores, los cuales permiten la comprensión de las potencialidades del contexto pedagógico para el desarrollo del proceso de atención logopédica integral.

Conciben que el niño no nace con los procesos psicológicos estructurados, pues toda su psiquis se desarrolla durante la actividad y la comunicación, basada en la educación y en la enseñanza socialmente organizada. En el segundo principio se destaca que la

psiquis humana no se puede dividir en funciones aisladas (lenguaje, memoria, percepción) debido a que constituye un sistema en el cual se incluye, de manera dialéctica y dinámica todos sus elementos.

Es por ello que el proceso de atención logopédica adquiere una connotación integral, no solo se trabaja las afectaciones del lenguaje y la comunicación en el nivel afectado, sino en relación con el resto de ellos y con todos los procesos psíquicos.

Desde el punto de vista lingüístico constituyen fundamentos de la atención logopédica integrar los aspectos relacionados con los procesos evolutivos del desarrollo de la expresión y la comprensión vistos en las etapas pre lingüísticas, del primer lenguaje y el lenguaje propiamente dicho. (Cabanas y Martínez. 2011)

Desde la concepción del Plan de Estudio E se postula que la atención logopédica integral no se restringe a la labor del logopeda, sino que debe ser un proceso que trascienda el trabajo del especialista junto a la acción de todos los agentes educativos que interactúan con los educandos diagnosticados con trastornos del lenguaje y la comunicación.

En relación con este fundamento está la participación de especialistas de ciencias médicas (otorrinolaringólogo, maxilofacial, neurólogos, foniatras, audiólogos, psiquiatras, foniatras entre otros) en el proceso de diagnóstico y ayuda a aquellos educandos con trastornos del lenguaje, el habla y la voz que demandas de su atención especializada y multi e inter disciplinaria.

Se considera que el Programa de la disciplina Logopedia guarda escasa relación con la neuropsicología, ya que en el sistema de contenidos de este programa y de todos los analizados no tiene siempre en cuenta, desde el diagnóstico y el tratamiento logopédico aspectos neuropsicológicos necesarios: técnicas, baterías de prueba para descartar alguna lesión en los diferentes sistemas de procesamiento. Dentro de las funciones y el campo de acción del logopeda no se contemplan suficientes contenidos que conduzcan a al conocimiento de esta ciencia tan importante y a fin con la carrera y que favorece a una formación inicial más integral.

3. MATERIAL DOCENTE

Introducción

Se considera material docente a todos los medios y recursos que facilitan el proceso enseñanza aprendizaje y la construcción de los aprendizajes, porque estimulan la función de los sentidos y activan las experiencias y aprendizajes previos, para acceder más fácilmente a la información, al desarrollo de habilidades, destrezas y a la formación de actitudes y valores (Sigüenza, 2015).

Asumiendo estos criterios se propone como **Material Docente** un ***Programa de Asignatura*** que permita enriquecer la formación inicial del logopeda en relación con la Neuropsicología del lenguaje y la Neurolingüística, ya que desde el diseño curricular no están concebidos estos contenidos los cuales han demostrado su pertinencia en el quehacer profesional tanto para el proceso de diagnóstico como para la atención logopédica integral.

El material docente elaborado tiene el propósito de lograr en los estudiantes:

- Contribuir a la adquisición de conocimientos de neuropsicología del lenguaje y neurolingüística.
- Estimular el desarrollo de habilidades para el diagnóstico y la atención logopédica integral en su desempeño profesional.
- Fortalecer el amor a la profesión
- Integrar contenidos de las disciplinas Logopedia, Piscología y Anatomía

Programa analítico

Universidad de Oriente

Facultad de Ciencias de la Educación Carrera:

Licenciatura en Educación Logopedia

PROGRAMA DE CURSO PROPIO

Asignatura: Neuropsicología cognitiva del lenguaje y neurolingüística.

Disciplina:

Plan de estudios: E

Año: 3er

Periodo: II Periodo

Fondo de tiempo: 44 horas clase.

Autor: Lic. Daniela Bertot Casals.

Año de elaboración: 2022

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA:

El sistema cognitivo humano con el cerebro como base material, tiene una función fundamental e indiscutible: la adaptación del individuo al medio. Para ello el sistema cognitivo cuenta con un conjunto de componentes estructurales y de mecanismos funcionales, que permite que la información que llega del medio en forma de estímulos ambientales, sea transformada en representaciones mentales. Estas últimas, una vez almacenadas en forma de experiencia en los componentes estructurales del sistema, a disantos niveles funcionales y con diferentes formatos representacionales, permiten organizar e interpretar la información entrante e identificar las demandas adaptativas del medio.

Todos los procesos mentales que permiten lo anterior son estudiados por la Psicología Cognitiva. Sin estos conocimientos no podríamos explicar y entender la conducta del hombre. Esto es un contenido básico que constituye la base sobre la que se asientan disciplinas dentro y fuera de la Psicología.

La neuropsicología cognitiva nace así como un intento de responder a dos cuestiones: a) qué síntomas, entre los que presenta un paciente, pueden ser explicados en términos del daño en uno o más componentes del sistema de procesamiento de la información y qué síntomas han de ser explicados en términos de estrategias compensatorias generadas por el sistema, y b) hasta qué punto las predicciones posibles acerca de las modificaciones de la función normal, hechas a partir de la lesión virtual de un componente de un modelo teórico de procesamiento de la información, se cumplen cuando resulta lesionado el «mismo» componente en un paciente neurológico.

La formación de un maestro logopeda que con perfil amplio pueda atender a los trastornos del lenguaje en niños, adolescentes y jóvenes de la ecuación regular y la ecuación especial, demanda de estos estudiantes en formación un conocimiento profundo del sistema nervioso central y su participación en la actividad verbal, lo que redundará positivamente en el diagnóstico y atención óptima a los trastornos del lenguaje que tienen como base disfunciones o desintegraciones de los sistemas funcionales que participan en esta compleja actividad.

Es por esta razón que en la formación inicial del logopeda se hace necesario formar en el estudiante aquellos conocimientos relacionados con la integración de los procesos mentales e intelectuales en el conocimiento del lenguaje y sus patologías. Para la realización de un buen diagnóstico y posteriormente tratamiento logopédico es imprescindible partir de la evaluación neurocognitiva del paciente, evaluar si hay daño a nivel cerebral, a nivel cognitivo y si existe algún sistema de procesamiento que no está cumpliendo su función. Esta asignatura pretende desarrollar competencias profesionales para su identificación, medición y la interpretación de los datos derivados de ello.

SISTEMAS DE OBJETIVOS:

- Identificar y caracterizar la arquitectura del sistema cognitivo humano para el procesamiento de la información y la regulación del comportamiento humano para la adaptación, así como argumentar la naturaleza biológica y social del lenguaje, puntualizando en las particularidades del código verbal en los diferentes formatos de presentación (oral, escrito, señas, etc.) y su procesamiento lingüístico y extralingüístico.
- Identificar las principales alteraciones del procesamiento cognitivo del lenguaje y sus consecuencias para el proceso de comunicación humana así como las alteraciones de la comunicación y sus implicaciones para el procesamiento del lenguaje.
- Argumentar los fundamentos teóricos y metodológicos de la neuropsicología cognitiva y de la neurolingüística, así como su relevancia para la comprensión y la atención especializada de los problemas de la comunicación asociados a alteraciones del procesamiento del lenguaje.
- Desarrollar habilidades para la exploración y el diagnóstico neuropsicológico de las alteraciones del lenguaje y la comunicación, a partir del uso de instrumentos de evaluación neurocognitiva y neurolingüística que apoyan el diagnóstico logopédico integral.

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE TIEMPO

Temas	**Cantidad de Horas**
Tema I	21
Tema II	23
Tema III	28
Total	**72**

SISTEMAS DE CONTENIDOS:

Tema 1. El procesamiento cognitivo de la información verbal.

Objetivo: Describir la arquitectura del sistema cognitivo humano con base en los modelos cognitivos contemporáneos más relevantes en la explicación del procesamiento de la información, así como identificar los subsistemas y componentes de procesamiento del sistema cognitivo que participan en el procesamiento lingüístico y extralingüístico de la información verbal.

Contenidos:

- Paradigmas teóricos en psicología cognitiva: Enfoque de Procesamiento de la Información y Enfoque del Procesamiento Distribuido en Paralelo. Arquitectura de la mente. Procesos horizontales y verticales.

- Subsistemas horizontales: La atención como mecanismo cognitivo, modelos teóricos de atención. El subsistema atencional y sus componentes fundamentales. El subsistema de memoria y aprendizaje. Formatos de almacenamiento y recuperación de la información en la memoria humana. Procesos de memoria. Mecanismos cognitivos del aprendizaje.

- Subsistemas verticales: El subsistema perceptivo-gnóstico. Modelos teóricos de percepción. Funciones del pensamiento: formación de conceptos, categorización, y solución de problemas. Organización semántica del conocimiento. Organización cognitiva de la acción. Sistema práxico. Componentes y mecanismos de procesamiento.

- Comunicación, lengua y lenguaje. Análisis filosófico, filológico y psicológico. Procesamiento lingüístico del código verbal: el Subsistema de Procesamiento del Lenguaje. Producción y comprensión del lenguaje oral; producción y comprensión del lenguaje escrito. La lectura como proceso cognitivo complejo: particularidades cognitivas y psicolingüísticas.

- Procesamiento extralingüístico del código verbal. Procesamiento perceptivo de la señal verbal. Los procesos de conversión acústico-fonémica. Procesamiento semántico de la información verbal. La organización del discurso.

Tema 2. Alteraciones cognitivas del procesamiento del lenguaje. Introducción a la neurolingüística.

Objetivo: Caracterizar las principales alteraciones cognitivas de la comunicación y del lenguaje en presencia de daño cerebral adquirido o desviaciones del desarrollo, así como distinguir las alteraciones del lenguaje de las alteraciones cognitivas de la comunicación.

Contenidos:

Las alteraciones cognitivas de la comunicación. Sistema perceptivo (procesos de conversión acústica-fonética). Sistema semántico. Sistema Práxico (conducto verbal, conducto no verbal). Subsistema de procesamiento del lenguaje. Particularidades para su identificación y diagnóstico. Alteraciones primarias y secundarias. Consideraciones necesarias para su distinción.

Trastornos del desarrollo el lenguaje. Trastorno específico del lenguaje. Aspectos conceptuales. Su tratamiento en los manuales diagnósticos. Trastornos del aprendizaje de la lectura. Su interacción con los trastornos generalizados del aprendizaje.

Las alteraciones del lenguaje. Trastornos adquiridos del lenguaje. Las afasias, las alexias y las agrafias. Aspectos conceptuales. Su tratamiento en los manuales diagnósticos. El enfoque cognitivo en su comprensión.

Tema 3. Evaluación y diagnóstico neuropsicológico y neurolingüístico de alteraciones de la comunicación y del lenguaje.

Objetivos: Aplicar instrumentos fundamentales para la exploración y el diagnóstico neuropsicológico y neurolingüístico de las alteraciones de la comunicación y el lenguaje.

Contenidos:

Fundamentos de la exploración y el diagnóstico neuropsicológico de las alteraciones del lenguaje. Estrategias de exploración neurolingüística.

Instrumentos para la exploración y el diagnóstico neurolingüístico de las alteraciones adquiridas del lenguaje.

Fundamentos de la exploración y el diagnóstico neuropsicológico de las alteraciones del lenguaje infantil. Estrategias de exploración neurolingüística en el contexto escolar.

Instrumentos para la exploración y el diagnóstico de las alteraciones del desarrollo del lenguaje.

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO POR FORMAS DE ENSEÑANZA

Tema		Conf.	Sem.	C/P	Total
I.	El procesamiento cognitivo de la información verbal.	8	4	9	21
II.	Alteraciones cognitivas del procesamiento del lenguaje. Introducción a la neurolingüística.	10	4	9	23
III.	Evaluación y tratamiento neuropsicológico y neurolingüístico de alteraciones de la comunicación y del lenguaje.	6	4	18	28

Total				72

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

La asignatura no tiene examen final. Su evaluación tiene lugar a través de:

- Evaluaciones frecuentes (preguntas orales y escritas)
- Examen parcial
- Trabajo extraclase (informe técnico del estudio de un caso clínico)

SISTEMA DE HABILIDADES:

- Identificar la arquitectura del sistema cognitivo humano
- Caracterizar las diferentes alteraciones del procesamiento cognitivo del lenguaje
- Explorar y diagnosticar desde la neuropsicología las alteraciones del lenguaje y la comunicación

SISTEMAS DE VALORES:

Respeto a las diferencias individuales y apertura hacia las personas con discapacidad

La responsabilidad con el consecuente nivel de eficacia y eficiencia personal

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

El tema 1 tiene como objetivo caracterizar la arquitectura del sistema cognitivo humano con base en los modelos cognitivos contemporáneos más relevantes en la explicación del procesamiento de la información, así como identificar los subsistemas y componentes de procesamiento del sistema cognitivo que participan en el procesamiento lingüístico y extralingüístico de la información verbal para lo cual debe partirse de la historia del problema de la localización de las funciones psíquicas como aparece en el libro Las funciones corticales superiores del hombre, resaltando las tendencias fundamentales en este problema.

Importancia capital tiene el estudio y explicación de la definición dada por Luria de funciones psíquicas superiores lo cual posibilita la comprensión de conceptos importantes como localización dinámica de las funciones, función y sistema funcional, conceptos que los alumnos deben dominar de manera esencial en esta asignatura para lo cual se sugiere la realización de fichas y resúmenes que permitan la apropiación de estos conceptos.

Se debe dedicar un espacio al análisis de las bases fisiológicas de procesos psíquicos como la memoria, el pensamiento, la memoria, la percepción, la atención y el lenguaje.

Se sugiere la realización de un seminario acerca de la generación del enunciado verbal para profundizar en los aspectos relacionados con este, cuestión ya tratada en la disciplina logopedia, pero que por su importancia es necesario retomar para garantizar la cabal comprensión de los aspectos centrales de esta asignatura.

El segundo seminario se puede dedicar al estudio de los sistemas perceptivo, atencional, de memoria, pensamiento y el lenguaje para que los alumnos puedan explicar estos aspectos de manera independiente y luego integrarlos en la producción del lenguaje.

El tema 2 puede comenzar a partir del estudio de las alteraciones del lenguaje. Es importante en esta parte del tema que se dedique atención a la organización funcional de los diferentes sectores corticales y cómo cada uno de ellos aporta desde el punto de vista neuropsicológico un elemento importante al sistema funcional del lenguaje, aquí debe quedar claro cuál es el eslabón del sistema funcional alterado en correspondencia con el análisis realizado acerca de la generación del enunciado vinculándolo con los analizadores que participan en la actividad verbal, lo cual les permitirá consolidar este contenido y comprender las peculiaridades de la organización y funcionamiento de la sección cortical de estos analizadores.

Un aspecto interesante lo constituyen los postulados de L. S. Svietkova acerca de la formación de las funciones psíquicas implicando el llamado campo de aferentación y

los principios para la rehabilitación formulados por ella y que se concretan de una u otra manera en el principio de la corrección y la compensación.

Es importante el análisis de la concepción de Wernicke de la estructura funcional del cerebro en relación con el mecanismo del lenguaje pues ella constituye la explicación fisiológica de la clasificación de las afasias que se utiliza en la actualidad, de manera que los alumnos puedan establecer la relación entre estas dos concepciones (Luria y Wernicke) y las clasificaciones empleadas en el diagnóstico de las afasias, destacando que ambas concepciones lejos de ser excluyentes constituyen puntos de vista que se complementan y que posibilitan en la actualidad el trabajo con los pacientes portadores de afasias.

Los seminarios irán dirigidos al estudio de las alteraciones del lenguaje caracterizando brevemente cada una de ellas, es importante recordar que en la disciplina logopedia se dedica un espacio a esto por lo que con el objetivo de no repetir contenidos aconsejamos que se analicen aquí los eslabones alterados dentro del sistema funcional y su repercusión general sin entrar a detallar desde el punto de vista logopédico toda la gama sintomática de cada alteración del lenguaje.

Deben ser tratados aspectos esenciales relacionados con las parálisis y sus tipos en correspondencia con la estructura alterada lo que facilitará la comprensión de las parálisis cerebrales y su síntoma verbal (disartria) considerándola como un síndrome y no solo como un síntoma verbal simple, pues en ellas aparecen trastornos en la respiración, la voz y el movimiento general.

El tema 3 está encaminado al estudio del diagnóstico neuropsicológico debe tener una primera parte dedicada al estudio de los actuales métodos clínicos para el diagnóstico de las lesiones de los sectores centrales del SNC aquí los estudiantes pueden buscar diferentes fuentes en las que se expliquen estos métodos así como imágenes de las diferentes pruebas realizadas, es importante que en esta parte se retomen los contenidos relacionados con la exploración neurológica estudiados en la disciplina Anatomía.

Posteriormente se debe realizar el estudio de la exploración neuropsicológica que aparece ampliamente demostrada en el texto de Luria Las funciones corticales superiores del hombre.

En las Clases Prácticas se trabajara con diferentes baterías de pruebas e instrumentos de exploración y evaluación neuropsicológica que le permitan al estudiante integrarlos en el diagnostico logopédico y en su posterior tratamiento.

Bibliografía:

- Berovides, V. (2011) Conducta humana ¿Herencia o ambiente? La Habana: Editorial Científico-Técnica.
- Benedet, M.J. (2002). Fundamentos teóricos y metodológicos de la neuropsicología cognitiva. Madrid: INSERSO.
- Benedet, M.J. (2006). Acercamiento neurolingüístico a las alteraciones del lenguaje. Fundamentos teóricos de la neurolingüística. Procesamiento normal del lenguaje. Madrid: EOS.
- Benítes, A (2006). Caracterización neuroanatómica y neurofisiológica del lenguaje humano. Revista Española de Lingüística, 35,2, págs. 461-494.
- Benítes, A (2017). Aspectos genéticos del lenguaje. Revista Española de Lingüística (RSEL) 3, pp. 103-137
- Cifuentes, J.L. (1996). Gramática cognitiva. Fundamentos críticos. Madrid: EUDEMA.
- Cubeira, A. (2005). Introducción a la teoría del lenguaje. La Habana: Universidad de la Habana.
- Dronkers, N.F., Pinker, S., & Damasio, A. (2004). Lenguaje y afasias. En E.R. Kandel, (Ed.), Principios de neurociencia (Cap. 59, pp.1169-85). Madrid: McGraw-Hill/Interamericana.

- Echavarría, R. (1998). Ontología del lenguaje. Santiago de Chile: Lom Ediciones S.A.
- Etchepareborda, M.C, López. L (2017): Estructura citoarquitectónica de las áreas del lenguaje. REV NEUROL 2017; 40 (Supl 1): S103-S106.
- Etchepareborda, M.C (2018). Bases neurobiológicas del desarrollo del lenguaje. REV NEUROL 2018; 41 (Supl 1): S99-S104.
- Fernández, G., Huepp, F. (2014). Fundamentos neuropsicológicos del lenguaje. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Martínez, E, Pardo, V.M, Antúnez, V.A (2013). Evolución histórica del concepto afasia: apuntes sobre su abordaje teórico en Neuropsicología. Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.
- Martínez, E, Rodríguez, Y, Pino, M. (2015). Peculiaridades neurocognitiva del procesamiento extralingüístico del código verbal. Revista Cubana de Neurología y Neurocirugía.
- Martínez, E, Rodríguez, Y, Del Prado, M (2019). Afasia, paciente afásico e investigación neurolingüística. Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.
- Martínez, E, Rodríguez, Y, Pino, M. (2019). Particularidades del procesamiento preléxico del código verbal en hispanohablantes. Evidencias neurolingüísticas. Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.
- Pérez, LA (2015) Genética y lenguaje. REV NEUROL 2015; 41 (Supl 1): S47-S50.
- Portellano, J.A. (2005). Introducción a la neuropsicología. Madrid: Mc Graw Hill.
- Rodríguez, Y., Bolaño, G.A., y Omar, E. (2017). Afasia, paciente afásico e investigación neurolingüística en Cuba: su abordaje científico.
- Trujillo, F., González, A., Cobo, P., y Cubillas, E. (2007). Nociones de fonética y fonología para la práctica educativa. Madrid: Grupo Editorial Universitario.

- Vihman, M. M. (2002) The role of mirror neurons in the ontogeny of speech. In Stamenov, Maxim & Victor Gallese. Mirror Neurons and the evolution of brain and language. Amsterdam: John Benjamins.

Evaluación de la estructura del Programa de Asignatura (validación teórica)

Diseño metodológico para la validación teórica del programa

Tipo de estudio.

La evaluación de la estructura o validación teórica del Programa de Asignatura, se realizó mediante un diseño cuantitativo transversal, no experimental, de tipo descriptivo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), con la participación de una población de Jueces Expertos, seleccionados según los siguientes criterios de selección.

Criterios de inclusión

1. Profesional de las ciencias de la educación, y/o la salud residente en Cuba y vinculado a instituciones nacionales, con formación y experiencia en la investigación, la docencia, y/o la preparación en temas relacionados con la neuropsicología, psicolingüística y la neurolingüística, la formación inicial del logopeda.

2. Experiencia profesional en su área de experticia superior a los 10 años.

3. Disposición a participar como Juez Experto del presente estudio.

4. Coeficiente de competencia entre 0.8 y 1, según Método Delphi.

Criterios de exclusión

1. Responder a la solicitud de colaboración en un periodo superior a dos semanas (14 días), a partir del momento en que se le envía por correo electrónico dicha solicitud.

2. Responder a la Encuesta a Expertos en un periodo superior a las 3 semanas (21 días), a partir del momento en que le fue enviada por correo electrónico dicha encuesta.

Métodos para la recogida de datos

Encuesta de Competencia. Con el objetivo de obtener la información necesaria sobre el nivel de conocimiento, la capacidad de comprensión y la experiencia profesional en el tema que se propone (anexo #).

Encuesta a Expertos. Con el objetivo de obtener los datos necesarios sobre la rigurosidad científica en la concepción del programa, la calidad de su formato de presentación, la claridad de los objetivos planteados, la estructura general del

programa, el orden lógico de los temas, la calidad de la redacción, así como la validez teórico- metodológica del programa (Anexo 9).

Métodos para el procesamiento estadístico de datos

Para la codificación y el procesamiento estadístico de datos se utilizaron bases de datos implementadas en hojas de cálculos Excel y en el Paquete Estadístico para la Ciencias Sociales (SPSS, según sus siglas en ingles), en la versión 22.0. Los métodos de procesamiento de datos fueron los siguientes:

- Método Delphi. Con el objetivo de calcular el Coeficiente de Competencia de los profesionales identificados como potenciales expertos.
- Coeficiente de Variación. Con el objetivo de calcular el nivel de concordancia de los expertos en relación a la estructura general del programa y la concepción de los contenidos incluidos en este, a partir de los criterios definidos para este propósito.

Criterios de evaluación de la estructura del Programa de Asignatura

Para la evaluación de la estructura del programa, se definieron varios criterios a tener en cuenta durante la validación teórica de programas de asignatura. Tales criterios se pueden agrupar en:

Criterios para la evaluación general del programa.

- Rigurosidad científica del programa
- Calidad del formato de presentación
- Presentación y claridad de los objetivos
- Estructura general del programa
- Orden lógico de los contenidos
- Pertinencia de la metodología utilizada
- Pertinencia general de los temas tratados
- Calidad de la redacción del programa.

Descripción del procedimiento

La validación teórica del Programa de Asignatura supuso dos etapas fundamentales: una primera etapa de selección de la población y la muestra correspondiente de Jueces Expertos, y una segunda etapa de evaluación de la estructura del programa propiamente.

Primera etapa:

La selección de los posibles expertos se realizó a partir de la revisión realizada en a documentos propios de la especialidad donde aparecen listados los docentes que más elevado nivel de experticia poseen en el tema objeto de estudio. Se revisaron varios sitios de internet desde donde se pudo determinar los autores más citados que han versado sobre este tema. Se atendió además a las sugerencias de los directivos administrativos y metodológicos de la carrera y la facultad.

Estos fueron listados, así como sus datos de localización (e-mail). A cada uno de estos autores le fue enviada la solicitud de colaboración como Juez Experto para la evaluación teórica del Programa, adjuntando la Encuesta de Competencia al mensaje de solicitud.

A todos los candidatos que respondieron afirmativamente en el periodo establecido (dos semanas posteriores al momento de envío de la solicitud) y completaron la referida Encuesta, se les calculó su Coeficiente de Competencia, a través del Método Delphi, programado en una hoja de cálculos Excel. Todos los candidatos fueron informados de su Coeficiente de Competencia.

Calculo del coeficiente de Competencia de Expertos									
Experto	**Gc**	**Ca**	**Ec**	**Et**	**CE**	**Cp**	**Kc**	**Ka**	**K**
1	8	0,12	0,16	0,12	0,12	0,12	0,8	0,64	0,72
2	8	0,16	0,16	0,2	0,16	0,16	0,8	0,84	0,82
3	8,5	0,12	0,2	0,16	0,16	0,2	0,85	0,84	0,845
4	8,5	0,16	0,12	0,2	0,16	0,16	0,85	0,8	0,825
5	8,25	0,16	0,16	0,16	0,2	0,16	0,83	0,84	0,833
6	8	0,16	0,12	0,2	0,2	0,12	0,8	0,8	0,8

7	8,63	0,2	0,16	0,2	0,16	0,16	0,86	0,88	0,871
8	7,88	0,16	0,16	0,16	0,2	0,12	0,79	0,8	0,794
9	8,38	0,2	0,16	0,2	0,16	0,2	0,84	0,92	0,879
10	8,5	0,16	0,2	0,16	0,12	0,16	0,85	0,8	0,825
11	7,75	0,2	0,16	0,12	0,16	0,16	0,78	0,8	0,788
12	8,25	0,16	0,2	0,12	0,2	0,2	0,83	0,88	0,853
13	8,13	0,16	0,12	0,2	0,16	0,2	0,81	0,84	0,826
14	7,5	0,16	0,12	0,16	0,12	0,16	0,75	0,72	0,735
15	8,38	0,2	0,16	0,2	0,2	0,2	0,84	0,96	0,899
16	7,75	0,16	0,12	0,12	0,16	0,2	0,78	0,76	0,768
17	8,13	0,16	0,16	0,2	0,2	0,16	0,81	0,88	0,846
18	8,25	0,2	0,2	0,16	0,2	0,16	0,83	0,92	0,873
19	8	0,16	0,16	0,2	0,16	0,2	0,8	0,88	0,84
20	8,25	0,16	0,16	0,12	0,2	0,2	0,83	0,84	0,833
21	8,5	0,2	0,16	0,16	0,12	0,2	0,85	0,84	0,845

Aquellos que cumplieron con los valores (entre 0.8 y 1) de dicho coeficiente, pasaron a formar la población de Jueces Expertos y fueron informados que serían sometidos a un muestreo para definir quienes finalmente participaría en la evaluación teórica del Programa.

A partir de los datos sobre edad, género, profesión, grado científico, categoría docente, categoría científica, institución de pertenencia, índice de publicaciones científicas y años de experiencia profesional, se realizó la caracterización socioprofesional de la población y de la muestra de expertos.

Segunda etapa:

Para la evaluación de la estructura del Programa, se le envió a cada uno de los profesionales que conformaron la muestra de Jueces Expertos, la Encuesta a Expertos. Una vez que cada experto completó y envió la referida Encuesta, primero se procedió a la codificación de los datos. Luego se analizaron las observaciones cualitativas y sugerencias realizadas por los expertos, sobre la estructura global. Para lo primero se

utilizó una hoja de Cálculos Excel, donde fue insertada la fórmula correspondiente al cálculo del coeficiente de variación.

A partir de ello, se obtuvieron los valores de media, desviación estándar y coeficiente de concordancia. En función de los valores obtenidos en cada caso, se identificó el nivel de validez de los indicadores para la evaluación global del programa y para la evaluación específica de cada sesión. A partir de los resultados del cálculo del coeficiente de variación y de las observaciones y sugerencias realizadas por los expertos, se revisó y modificó el Programa de Asignatura.

Resultados y discusión de la validación teórica del Programa de asignatura

Los resultados de la validación teórica del Programa de Asignatura, se constituyó en tres acápites. En el primero se presenta una caracterización socioprofesional de los Expertos. En el segundo se muestran los resultados de la evaluación de la estructura del programa propiamente. En el tercero se discute los resultados de dicha evaluación.

Caracterización socioprofesional de la población de Jueces Expertos

Como resultado de la aplicación del Método bibliométrico para la identificación de candidatos a expertos, se obtuvo una cifra total de 23 profesionales pertenecientes a diferentes instituciones de educación superior y salud pública del país. De estos 23 candidatos, el 86.9% (20 profesionales) confirmó su interés en participar como experto en la evaluación del programa, contando todos los casos con más de 10 años de ejercicio profesional en su posible área de experticia.

Luego del cálculo del Coeficiente de Competencia de estos 20 candidatos, se obtuvo que solo el 85% (17 casos) cumple con este criterio de selección. De este modo, la población de estudio quedó conformada por 17 profesionales. El 77,3% de la población de Jueces Expertos es de género femenino y el 22,7% de género masculino. El 47% registra más de 40 años de experiencia profesional, el 23% de 15 a 20años de experiencia, el 30% más de 10 años de experiencia profesional.

Estos profesionales registran un promedio de 7.13 publicaciones científicas realizadas en los últimos 10 años, con una desviación estándar de 4.527, en un rango de 4 a 19

por autor, para una cifra total de 173 publicaciones. El Coeficiente de Competencia promedio es de 0.91, con una desviación estándar de 0.047, en un rango de 0.80 a 0.98.

El 82% de la población de expertos es graduado de educación en Logopedia, el 0,05% de salud, el 11% de Psicopedagogía. El 77% de los casos son doctores en ciencias, de estos, el 65% en ciencias pedagógicas, y el 12% en ciencias de la salud. El 37.5% a la Universidad de Oriente, el 39% a la Universidad Oscar Lucero Moya de Holguín, el 23% a la Universidad de Pinar del Rio, el 0,5% Universidad de Ciencias Médicas. El 58% son profesores titulares, el 42% profesores auxiliares.

Resultados de la validación teórica del Programa de Asignatura

En el análisis del nivel de concordancia global de los expertos en relación a la estructura general del programa, a partir del cálculo de su Coeficiente de Variación (CV), se obtuvo como resultado que todos los indicadores para la evaluación general del programa, obtuvieron valores de M (promedio) superiores a 4.50 (90% del valor máximo posible a alcanzar) y valores de CV entre 0 y 0.20 (ver tabla). Estos datos indican que tales indicadores son válidos y, por tanto, no requieren modificaciones.

En el caso del indicador 5 (orden lógico de los contenidos), aun cuando los datos muestran que es válido, algunos expertos recomendaron la pertinencia de agregar en los contenidos del Tema III, el tratamiento a los trastornos del lenguaje y la comunicación. Teniendo en cuenta que el programa solo se planteaba abordar hasta el diagnóstico.

También fue considerado por los expertos que se debía valorar la pertinencia del programa en el año que se propone (2do año), consideran que es más pertinente incluirlo en el 3er año de la carrera, II semestre dado que en este año los estudiantes comienzan a recibir la asignatura Logopedia por lo que abordan los trastornos del lenguaje y en las practicas pre-profesionales pueden integrar los contenidos de la asignatura que se propone con los trastornos del lenguaje que se abordan desde la Logopedia tanto para su diagnóstico como para su tratamiento.

Discusión de los resultados de la evaluación teórica del Programa de Asignatura

Para la evaluación de la estructura del Programa de Asignatura (validación teórica) se tuvieron en cuenta criterios cuantitativos y cualitativos. En el primer caso se utilizó el nivel de concordancia global de los expertos, obtenido a partir del cálculo de su Coeficiente de Variación (CV) para la evaluación general.

En todos los indicadores obtuvieron valores de M (promedio) superiores a 4.50 (90% del valor máximo posible a alcanzar) y valores de CV entre 0 y 0.20, fueron interpretados como válidos. A pesar de que todos los indicadores resultaron validos se tomó en consideración la valoración cualitativa del proceso y en algunos indicadores se realizaron cambios a partir de las sugerencias realizadas por los expertos.

No Experto	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5	5	4	5	4	5	5	5
2	4	5	5	5	5	5	5	5
3	5	4	5	5	5	5	4	5
4	5	4	5	5	5	3	4	5
5	4	5	5	5	5	4	5	3
6	5	5	5	4	5	4	4	5
7	5	5	5	5	5	5	5	5
8	5	5	5	5	3	5	5	5
9	4	5	5	5	5	5	5	5
10	5	5	4	5	4	5	5	5
11	4	5	5	4	3	5	4	5
12	5	4	5	5	5	5	5	5
13	5	4	5	5	5	3	5	5
14	5	5	5	5	5	4	4	4
15	5	5	5	4	5	4	4	5
16	4	5	5	4	5	5	5	4
17	5	5	5	4	3	5	4	5
Promedio	4,71	4,76	4,88	4,71	4,53	4,53	4,59	4,76
Desv. Estándar	0,47	0,44	0,33	0,47	0,8	0,72	0,51	0,56
Coef. de Var.	0,1	0,09	0,07	0,1	0,18	0,16	0,11	0,12

El proceder de validación teórica de los programas de asignaturas en comparación con otros consultados por la autora, no es realizado de la misma manera en todas las investigaciones. Existen autores que realizan la validación teórica solo teniendo en cuenta criterios cualitativos de valoración de la pertinencia de su propuesta.

Por otra parte se encontraron autores que tienen en cuenta en el proceso de validación los criterios cuantitativos y cualitativos para la evaluación de la estructura de los programas (validación teórica). De forma general, considerando el análisis cuantitativo y cualitativo realizado, se evidencia que el Programa de Asignatura es válido a pesar de las sugerencias.

Conclusiones parciales de la validación teórica del Programa de Asignatura

1. Se tomaron en cuenta sus valoraciones cualitativas y cuantitativas en el procesamiento de los datos de la encuesta aplicada a los expertos. A partir de dichos datos se realizan modificaciones pertinentes al Programa de Asignatura, en función de mejorar su nivel de validez teórica.

2. Se demostró que el Programa de Asignatura para el abordaje de la neuropsicología y la neurolingüística en la formación inicial del Logopeda muestra validez teórica.

CONCLUSIONES

El diagnóstico realizado permitió corroborar la existencia de insuficiencias en el desempeño pre-profesional de los estudiantes de la carrera de Logopedia relacionadas con la escasa efectividad en la realización del diagnóstico a niños y niñas con trastornos en el lenguaje y la comunicación, y en consecuencia la poca efectividad en el tratamiento logopédico indicado; dichas limitaciones inciden negativamente en la formación inicial de estos profesionales de la educación.

Los referentes teórico-metodológicos en los cuales se profundizó durante el proceso de la investigación, han posibilitado comprender los procesos de formación inicial de los profesionales de Logopedia, enfatizando en su desempeño pre profesional. Se constatan entre los valiosos aportes de numerosos autores la coherencia en relación con la importancia de la adecuada preparación de estos estudiantes; sin embargo el aparato teórico conceptual adolece de una suficiente consistencia que permita entender el papel de las neurociencias, con énfasis en neuropsicología y neurolingüística para la preparación académica y metodológica de los futuros profesionales de la educación que atienden a los niños y niñas con trastornos del lenguaje y la comunicación.

El programa de asignatura elaborado posee contenidos necesarios para la formación inicial, toda vez que aborda nociones de neuropsicología y neurolingüística, útiles para el desempeño pre profesional de los estudiantes de Logopedia.

Según los criterios de los expertos consultados, el programa de asignatura Neuropsicología cognitiva del lenguaje y neurolingüística, es válido teórica y metodológicamente para insertarlo en el tercer año de la carrera Licenciatura en Educación Logopedia.

RECOMENDACIONES

1. A la investigadora:
   - Divulgar el material docente entre los docentes de la carrera
   - Continuar enriqueciendo el Programa de Asignatura propuesto según las demandas y los avances de la Ciencia.
2. A los directivos de la carrera: Velar por la implementación del programa en el tercer año de la carrera objeto de análisis.

BIBLIOGRAFIA

- Addine, F. (2013). La didáctica general y su enseñanza en la educación superior pedagógica. Aportes e impactos. La Habana. Pueblo y Educación.
- Álvarez, C. (1984). Perfeccionamiento de los planes de estudio de la Educación Superior. En Varona. -- Año VI, no. 12. -- La Habana, ene-jun. 1984.
- Álvarez, L. (2008). Logopedia y foniatría. Editorial Ciencias Médicas, La Habana
- Álvarez, L. (2005). Entrenamiento en Logopedia para Defectólogos. Módulo I y IV. Villa Clara, MINSAP.
- Artigas, J. (2008). Trastornos del lenguaje. Protocolos, diagnóstico terapéutico. Neurología pediátrica. Asociación Española de Pediatría. www.aeped.es/protocolos/.
- Azcoaga, J. E. (2003) Del lenguaje al pensamiento verbal. Editorial Pueblo y Educación. La Habana.
- Belinchon, M, Riviere, A, Igoa, JM (1992). Psicología del lenguaje. Investigación y teoría. Madrid: Trotta
- Bell, R. (2000). Diversidad e integración curricular: Implicaciones para la formación docente en Preescolar, Primaria y Especial. Cuba.
- Barreras, D, Hoyos, E, Rojas, S (2010). Caracterización del perfil neuropsicológico de un niño de 6 años con trastornos del lenguaje: estudio de caso. Researchgate.net
- Benedet, M.J. (2002). Fundamento teórico y metodológico de la Neuropsicología Cognitiva. Madrid: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO).
- Benedet, M.J. (2006). Acercamiento neurolingüístico a las alteraciones del lenguaje. Tomo I. Madrid: Editorial EOS
- Bringas, ML (2009): La Neuropsicología en Cuba. Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, vol.9, N2, pp 53-76
- Bolaños, JA (2018). Formación pedagógica en el ambiente escolar. Repositorio.ug.edu.ec

- Caballero, E (2012). La creatividad pedagógica en la formación del docente. Didáctica y Educación.dialnet.unirioja.es
- Caplan, D (1992). Language, Neural Basis of. Massachusetts general Hospital
- Cardoza, E. (2020) La promoción de la cultura rural montañesa en los estudiantes de la Licenciatura en educación Primaria. Tesis en opción al grado científico de doctor en ciencia pedagógicas. Universidad de Oriente.
- Cervera, JF, D´Eusebio, E y Torres, E. (2020): Seminario Internacional sobre el ejercicio de la profesional de la Logopedia. Seminario de la Universidad Católica de Valencia, España.
- Cobas, C. y López, R. (2010). Selección de temas para la formación del maestro logopeda. Editorial Pueblo y Educación. La Habana.
- Cobas, C, López, R. (2010). Temas logopédicos para docentes. Editorial Pueblo y Educación. La Habana.
- Colectivo de autores. (1992-1993, 2001). Informe Reunión Comisiones de Carreras. Cambios que se han operado en los Planes de Estudio de Carreras Pedagógicas posteriores a su vigencia.
- Colectivo de autores. (2008). Logopedia y Foniatría. Editorial ECIMED. La Habana
- Colectivo de autores. (2008). Manual de técnicas logofoniátricas. Editorial Ciencias Médicas, La Habana.
- Colectivo de autores. (2015). Didáctica de la Pedagogía y la Psicología. Editorial. Pueblo y Educación. La Habana.
- Colectivo de autores. Programas de la Disciplina Logopedia, UCPRMM. Facultad de Educación Infantil, planes de estudio A, C, D y E.
- Cuba, E. (2012). Introducción a los estudios lingüísticos. La Habana: Editorial. Pueblo y Educación.
- Contreras, J.M (2011). Estudios pioneros en torno al origen del lenguaje natural. arbor-revistas.csic.es

- Chirino, M. (2002): Perfeccionamiento de la formación inicial investigativa de los profesionales de la educación. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona. La Habana.
- Del Moral, L. (2018): La realidad de la Logopedia en Europa como estudiante de Erasmus. Universidad de Valladolid
- Díaz, M. L. (2010). Modelo didáctico para perfeccionar la formación inicial del maestro de Educación Especial. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias pedagógicas. La Habana. Cuba.
- Echavarría, L.M (2022). Neurociencias.
- Fernández, G, Rodríguez, X. (2011): Textos para los estudiantes de las carreras Licenciatura en Logopedia y Educación Especial (Primera parte). La Habana.
- Fernández, G, Huepp, F. (2014): Fundamentos Neuropsicológicos del lenguaje. La Habana.
- Fernández, G (2015): La Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona en la fomación del logopeda en Cuba. Universidad Pedagógica Enrique José Varona, La Habana, Cuba, num.60, pp. 19-29.
- Ferreiro, R. (1986). Anatomía y Fisiología del desarrollo e Higiene Escolar. Editorial Pueblo y Educación. Cuba.
- Freire (2017). Formación continua en la formación docente. Revista Conrado-conrado.ucf.edu.cu
- Frias, X (2002). Introducción a la Psicolingüística. Revista Psicológica Romanica
- Fuentes, H. (1997). Modelo del diseño curricular según la lógica de la actuación del profesional. Materiales de la maestría de Ciencias de la Educación – Universidad de Oriente, Santiago de Cuba.
- Garayzábal, E y Otero, MP (2005). Psicolingüística, Neurolingüística, Logopedia y Lingüística Clínica: Juntos si pero no revueltos. Filología y Lingüística XXXI (1):163-185, 2005.

- Gallardo, B (2002). Fronteras disciplinarias pragmática y patología del lenguaje. En: Hernández Sancristan y Serra Alegre.
- Garcia, M, Ruiz, M. L (2001). Actitudes hacia la atención a la diversidad en la formación inicial del profesorado. dialnet.unirioja.es.
- Gatell, A, Martínez, RM (2021). La formación integral del estudiante universitario desde un enfoque sociocultural. Revista cubana de scielo.sld.cu.
- González, MJ, Montes, MV (2020). Neuropsicología. repositorios.comillas.edu
- Hernandez, I (2010). Aproximación a la neuropsicología y trastornos del lenguaje. Boletín de lingüística-ve.scielo.org.
- Lepe, N, Pérez, C (2018): Funciones ejecutivas en niños con trastorno del lenguaje: algunos antecedentes desde la neuropsicología. Universidad Católica del Ecuador.
- Herrán, A, Pérez, E (2012). Reflexiones didácticas sobre el componente sociohumanistico en la formación creativa del arquitecto. Calidad y Eficacia- repositorio.uam.es
- Kandel, E (1996). Neurociencia y aprendizaje. Ciudad de México.
- Kandel, E (1997). Neurociencias y conducta. pesquisa.bvsalud.org.
- Kandel, E (2014). Principios de neurociencias. AMGH Editora, 2014.
- Kolb, B (2006). Neuropsicología humana. books.google.com.
- Lima-Silva, M.; Ferreira, L.; Oliveira, I.; Ghirardi, A (2012). Voice disorders in teachers: self-report, auditory-perceptive assessment of voice and vocal fold assessment. Rev Soc Bras Fonoaudiol [Internet]. 2012 [citado 12 Dic 2013];17(4):[aprox.3p].
- Luque, JdD, Hernández, A (2000). Trastornos del lenguaje: una perspectiva logopédica y lingüística. Granada: Método
- Luria, A. R. Las funciones corticales superiores del hombre. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1980.
- Marcelo, C (2002). La formación inicial y permanente de los educadores. idus.us.es

- Martínez, L, Hernández, R, Martínez, LM, Cerutti, M, Malebrn, C. (2006): La logopedia en Iberoamérica. XXV Congreso de Logopedia, Foniatría y Audiología. Granada, España.
- Matute, E (2012). Tendencias actuales de las neurociencias cognitivas. books.google.com
- MES. (2016). Modelo del profesional. Plan de Estudio E. Carrera Licenciatura en Educación Logopedia. La Habana.
- MES. (2016). Indicaciones Metodológicas y de Organización. Plan de Estudio "E". Carrera de Licenciatura en Educación Logopedia. La Habana.
- MES. (2016). Plan de estudio "E" Carrera Licenciatura en Educación Logopedia. La Habana.
- Mendoza, E (2012). La investigación actual en el Trastorno Especifico del Lenguaje. Revista de logopedia, foniatría y audiología.
- Miranda, T (2011). El modo de actuación profesional y su formación en las carreras pedagógicas. Varona-redalyc.org
- Murillo, LD, Ramos, DY (2020). Estrategias educativas inclusivas y su relación con la autoeficacia de docentes en formación. scielo.sa.cr
- Parra, C (2004). Apuntes sobre la investigación formativa. Educación y educadores-unisabana.edu.co
- Piñon, F, Mosquera, D (2022). Elementos teóricos para la construcción de un modelo de formación transversal. Revista paca-journalusco.edu.co
- Portellano, JA (2005). Introducción a la Neuropsicología. Universidad Complutense de Madrid
- Quintanar, L, Solovieva, Y. (2002): Análisis Neuropsicológico de las Alteraciones del lenguaje. Universidad Autónoma de puebla, México.
- Ripoll, DR (2014). Neurociencia cognitiva. academia.edu
- Sanguineti, JJ (2007). Filosofía de la mente. academia.edu
- Siguenza, J (2015). Diseño de materiales docentes multimedia en entornos virtuales de enseñanza- aprendizaje. Recuperado de http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num8/siguenza.html

ANEXOS

Anexo 1. Guía de observación a la práctica pre profesional de los estudiantes seleccionados

Objetivo: Describir el desempeño de los estudiantes seleccionados durante su práctica pre profesional en el gabinete logopédico.

Propuesta de indicadores a evaluar:

Dimensión 1: organización teórico- metodológica de la clase logopédica

- Planificación de la clase según el diagnóstico de los estudiantes
- Relación objetivo – tratamiento
- Exploración de procesos psíquicos
- Demostración de los métodos logopédicos concebidos para la actividad

Dimensión 2: medios de enseñanza

- Utilización de medios para la exploración y el tratamiento logopédico.
- Concepción de otros medios complementarios para lograr el tratamiento.

Anexo 2. Entrevista a familiares

Objetivo: Conocer los criterios que poseen los familiares sobre el tratamiento logopédico ofrecido a los niños por los estudiantes universitarios seleccionados.

- Datos generales de sexo, edad, preocupación o motivo de la visita.

- ¿Se siente satisfecho con el tratamiento logopédico que los estudiantes de la Universidad ofrecen a su hijo (a)?

- ¿Los estudiantes garantizan la continuidad del tratamiento logopédico en el hogar?

- Ha observado usted alguna manifestación de rechazo por parte de su hijo (a) hacia el tratamiento logopédico?

- Otras preguntas de interés según el curso de la entrevista relacionado con el objetivo de la misma.

Anexo: 3. Aspectos a considerar en el análisis de contenido

Objetivo: Recopilar información en los documentos normativos sobre la concepción de la preparación de los estudiantes de Logopedia en neurociencias.

Documentos revisados

- Modelo del profesional
- planes de estudio A, C, D y E
- programas de la disciplina
- Informes de validación de la carrera
- Exámenes integradores

Aspectos tenidos en cuenta para la búsqueda documental.

- Problemas profesionales del logopeda.

- Habilidades pedagógicas profesionales a las que tributa

- Equilibrio teórico práctico del contenido

- Bases fisiológicas del lenguaje

En relación con la bibliografía

- Contiene bibliografía, materiales de apoyo, manual de ejercicios, diapositivas entre otros documentos que:

- Posibilitan el dominio de las bases fisiológicas del lenguaje y que borden contenidos de neuropsicología.

- Favorecen el trabajo preventivo, correctivo y/o compensatorio

Anexo 4. Encuesta a logopedas.

Objetivo: Obtener criterios sobre el desempeño pre profesional de los estudiantes.

Compañero (a): Teniendo en cuenta su experiencia profesional en la especialidad, consideramos que su opinión será de gran utilidad para la actual investigación, por lo que solicitamos su valiosa colaboración y agradecemos la información que nos ofrece.

Preguntas:

1. ¿Cómo considera usted sobre la preparación de los estudiantes que realizan la práctica pre profesional en su gabinete?

Marque con una x.

Logrado____ poco logrado____ no logrado____

2. Mencione los conocimientos que usted considera les falta a los estudiantes.

_____ _____

_____ _____

3. Marque las que considere opciones correctas

Los estudiantes deben dominar los conocimientos de:

_ Neurolingüística

_ Psicología

_ Neuropsicología

_ Anatomía patológica.

4. Considera necesarios los conocimientos de neurociencias para la formación del logopeda.
   Sí__ No__ Por qué_____

Anexo 5. Guía de entrevista a profesores de la carrera

Objetivo: Complementar la información sobre la importancia de la neuropsicología en los estudiantes de la carrera Logopedia desde la opinión de sus profesores.

Estimado profesor(a): Teniendo en cuenta su experiencia profesional en la formación inicial del Logopeda y como miembro del colectivo de disciplina, consideramos que su opinión será de gran utilidad para esta investigación, por lo que solicitamos su valiosa colaboración y agradecemos la información que nos ofrece.

Datos generales del entrevistado:

Nombres y apellidos: _____

Asignatura que imparte: _____ Años de experiencia_____

Grado científico_____

1. Considera que los conocimientos que alcanzan los estudiantes en la carrera sobre neurociencias complementen su formación. ¿Cuáles?
3. Valore el alcance de los contenidos que se proponen en los programas actuales en relación con el dominio de neurociencias que necesita un logopeda.
4. ¿Qué importancia le confiere a la implementación de un programa de asignatura que aborde contenidos de neuropsicología?
5. Cómo evalúa la formación inicial del maestro logopeda.

Anexo 6 Encuesta para la determinación del Coeficiente de Competencia de los expertos

La presente encuentra ha sido elaborada con la intención de seleccionar a un grupo de profesionales de las Educación en Logopedia, que cuenten con la voluntad, la experiencia y la experticia en la formación de inicial de los logopedas, que les permita desempeñarse como jueces expertos en la validación teórica de un Programa de Asignatura sobre Neuropsicología , neurolingüística y psicolingüística, dado a la importancia de estos conocimientos para la formación integral del futuro profesional

Es por ello que le hemos preseleccionado como potencial experto para el referido propósito, obviamente si está usted consiente formar parte de este grupo de profesionales antes referido.

SI ESTÁ DE ACUERDO EN PARTICIPAR como juez experto en la validación teórica de un Programa de Asignatura se hace necesario que complete los siguientes datos generales y que, a partir de su autoevaluación, responda a algunas afirmaciones que se presentan seguidamente.

SI NO ESTÁ DE ACUERDO EN PARTICIPAR , le agradecemos su atención y esperamos poder contar con su sapiencia en otras oportunidades.

I. Datos generales:

1. Titulación de pregrado:
2. Nivel académico: *Máster* ___

_____

3. Grado científico:

Especialidad:

Área del conocimiento:

4. Formación en diplomados: *Si* ___ *No* ___

Especialidad:

5. Institución laboral:
6. Instituciones donde haya laborado previamente:

_____

7. Categoría Docente: Titular ___Auxiliar ___ Asistente ____Instructor ___
8. Categoría Científica: *Titular* ___*Auxiliar* ___ *Agregado* ____*Aspirante a Investigador* ____
9. Años de experiencia profesional: _____

II. Autoevaluación

1. A continuación, aparecen varias afirmaciones en relación a su conocimiento sobre elaboración de programas de asignaturas, que son fundamentales para evaluar óptimamente nuestro *Programa.* En la escala que se presenta, el **10** se corresponde con el conocimiento máximo y el **0** con el conocimiento mínimo. Marque con una cruz (**X**) el grado de conocimiento que usted considera tener acerca de estas afirmaciones.

Grado de Conocimientos	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Poseo conocimientos sobre la elaboración de programas de asignaturas en la formación inicial del logopeda.											
2. Poseo conocimientos sobre diseño curricular.											
3. Poseo conocimientos sobre neuropsicología.											
4. Poseo conocimientos sobre neurolingüística.											
5. Poseo conocimientos sobre psicolingüística.											
6. Poseo conocimientos sobre instrumentos neuropsicológicos para el diagnóstico y tratamiento a los trastornos del lenguaje											
7. Poseo conocimientos sobre instrumentos neurolingüística para el diagnóstico y tratamiento a los trastornos del lenguaje											

2. Valore las siguientes afirmaciones. Marque con una cruz (**X**) para evaluar la forma en que considera su estado en relación a cada una de ellas:

Fuentes de argumentación	Muy alto	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo
1. Capacidad para el análisis teórico de temas relacionados con la Neuropsicología, neurolingüística y psicolingüística.					
2. Experiencia profesional en temas relacionados con la elaboración y validación de Programas de Asignatura para la formación inicial del logopeda.					
3. Participación en investigaciones sobre Neuropsicología, neurolingüística y psicolingüística.					
4. Superación recibida y conocimientos actualizados sobre elaboración y validación de programas de asignatura.					
5. Comprensión de temas relacionados con la Neuropsicología , neurolingüística y psicolingüística.en vínculo con la Logopedia.					

Anexo 7. Encuesta a Expertos Para Validación Teórica de Programa de Asignatura

Estimado experto, a continuación, se presenta la encuesta elaborada con el objetivo de someter a su juicio y experticie, nuestro *Programa de Asignatura sobre Neuropsicología, Neurolingüística y Psicolingüística* para contribuir a la formación inicial del logopeda.

La encuesta está organizada con los aspectos generales del programa. Para cada uno de los ítems de la encuesta, hay cinco opciones de respuesta:

5. Muy adecuado/a.
4. Adecuado/a.
3. Casi adecuado/a.
2. Inadecuado/a.
1. Muy inadecuado/a.

Usted marcará con una X en la celda correspondiente a cada ítem, según su criterio de evaluación. Por cada ítem también se incluye en la misma fila una celda donde puede poner directamente sus sugerencias y sus observaciones. Las observaciones generales las debe incluir al final de la encuesta, en el lugar señalado para ello. Agradecemos sinceramente su amable participación como experto en nuestra investigación.

	Aspectos generales del programa	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**Observaciones y sugerencias**
1	Rigurosidad científica en la concepción del programa.						
2	Calidad del formato de presentación del programa.						
3	Presentación y claridad de los objetivos generales.						
4	Estructura general del programa.						
5	Orden lógico de los contenidos.						
6	Pertinencia de la metodología utilizada.						
7	Pertinencia general de los temas tratados.						
8	Calidad de la redacción del programa.						

Observaciones generales